

SAÚDE A MULHER

PROPOSTAS GERAIS:

- 1 - Instituir o acesso a realização de U.S. morfológico obstétrico como rotina de Pré-natal;
- 2 - Instituir o acesso a realização de U.S. com Doppler no acompanhamento do Pré-natal;
- 3 - Instituir o acesso a histeroscopia no sistema de saúde como rotina;
- 4 - Garantir o acesso a mamografia, em mulheres com 40 anos ou mais no sistema de forma universal;
- 5 - Garantir o acesso a todas as mulheres a inserção do método contraceptivo Implanon como rotina ambulatorial;
- 6 - Implementar o método de teste molecular de HPV na faixa etária de 25 á 64 anos para controle do câncer de colo de útero;
- 7- Ampliar o acesso a realização de U.S. Endovaginal para monitoramento de posição do DIU e fluxo direcionado a essa finalidade;
- 8 - Instituir o acesso a realização de U.S. Endovaginal com pesquisa de endometriose como rotina ginecológica;
- 9 - Disponibilizar creme de estradiol nos casos de atrofia vaginal, climatério na RENAME;
- 10 - Disponibilizar o tratamento hormonal de endometriose na RENAME;
- 11 - Ampliar a faixa etária de acesso à vacina HPV de 9 a 30 anos;
- 12 - Garantir o acesso a todas as mulheres a inserção do DIU hormonal como rotina;
- 13 - Implementar na avaliação ginecológica a utilização de teste das amins e verificação de PH vaginal por meio da utilização de fitas;
- 14 - Garantir acesso a tratamento hormonal das mulheres no climatério e menopausa quando necessário levando em consideração o custo benefício;
- 15 - Ampliar o acesso a realização de fisioterapia uroginecológica/pélvica com aumento de vagas;
- 16 - Instituir a fisioterapia pélvica durante o Pré-natal;
- 17 - Disponibilizar lubrificante vaginal à base de água.
- 18- Inserir atendimento ambulatorial em Medicina Chinesa e Práticas integrativas no Saúde da Mulher com atendimentos individuais.

- 19- Garantir inclusão da angioplastia
- 20- Garantir e ampliar o acesso à prática de atividade física para prevenção de sarcopenia em mulheres no climatério e menopausa.
21. Garantir que os agendamentos de exames seja a nível regional e ou central facilitando o acesso ao usuário
22. Permitir acesso mediante a credibilidade com o recebimento do resultado do exame de PCCU em tempo oportuno, para garantir possibilidade de tratamento quando necessário.
23. Acesso a usuária que se sente constrangida e/ou recusa em realizar o Exame preventivo (PCCU) com profissional do sexo masculino.
24. Garantir infraestrutura adequada com ampliação e melhorias do espaço físico das unidades de saúde
25. Garantia de assistência em Saúde Mental das mulheres, promovendo melhorias em vários âmbitos da saúde desta mulher.
26. Garantir acesso em saúde da mulher no climatério/menopausa com atendimentos e cuidado diferenciado
27. Criar unidade móvel em Saúde da mulher, assim como é realizado o suporte, oportuniza a odontologia com Odontomóvel e a realização/ atualização de vacinas, com o Vacimóvel.
28. Fortalecimento das ações de educação em saúde reprodutiva, contribuindo principalmente para redução da gravidez na adolescência. Objetivo de ensinar essas meninas quanto ao corpo e sua saúde prevenindo inclusive quanto a doenças sexualmente transmissíveis;
29. Garantir mais profissionais psicólogos e assim, acesso a este serviço para mulheres, uma necessidade urgente para melhoria de qualidade de vida e trabalho.
30. Melhorar acesso aos usuários quanto a infraestrutura e a otimizar os atendimentos referente a tempo de espera e qualidade deste momento. Fiscalizar os locais de atendimentos;
31. Garantir terapia ocupacional para as mulheres no âmbito das unidades de saúde, inclusive dentro das unidades de saúde.
32. Garantir investigação e diagnóstico em Neuro Divergências na população feminina de Montes Claros

PRESTADORES DE SERVIÇOS E PCDS

Propostas:

1. Propõe-se a implementação de ações de capacitação continuada para os profissionais da rede pública de saúde, com o objetivo de qualificar o atendimento às pessoas com deficiência. Essas capacitações devem contemplar a identificação precoce de deficiências, diagnóstico, manejo e acolhimento dos pacientes e encaminhamento adequado para as especialidades necessárias, do mesmo modo a orientação adequada aos pacientes e familiares, bem como a promoção de um atendimento humanizado, acessível e inclusivo em todos os níveis de atenção à saúde;
2. Capacitar os profissionais sobre deficiências raras e/ou ocultas como por exemplo: fibromialgia, doenças raras, Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) , Autismo, Visão monocular, Síndrome de Down etc;
3. Os deficientes visuais estão tendo dificuldade de realizar a biometria facial (uma vez que o programa identifica pela íris a face) em bancos, no aplicativo gov, etc. Assim, os deficientes visuais que não possuem a íris dos olhos, não conseguem fazer o reconhecimento e atendimento, portanto faz-se necessário uma nova forma dos programas realizarem o cadastro reconhecimento facial destes públicos;
4. Propõe-se que a SMS estude meios de priorizar as pessoas com deficiência (PCDs) no sistema Mais Saúde Digital da empresa Vivver para todos os procedimentos;
5. Propõe-se que a SMS disponibilize intérpretes de Libras na própria secretaria e demais unidades de saúde, caso no município não tenha implementado a central intérprete de libras(CIL);
6. Propõe-se implementar a central intérprete de libras (CIL) no município, por meio de parceria com terceiro setor, com a abertura de edital público pela SMS para financiamento e apoio institucional, garantindo a acessibilidade comunicacional às pessoas surdas sinalizantes de libras nos serviços de saúde. A central deverá disponibilizar intérpretes de libras para atendimento presencial e virtual, assegurando suporte comunicacional em consultas, orientações e demais atendimentos na rede municipal de saúde;
7. Propõe-se a sinalização dos pontos de embarque e dos transportes de pessoas com deficiência, bem como do transporte sanitário;
8. Propõe-se que haja treinamento para o profissional médico assinar os laudos para pacientes com deficiência (PCD) através do portal GOV BR;
9. Propõe-se a ampliação do acesso das pessoas com deficiência visual aos serviços oftalmológicos na rede pública de saúde, com a realização periódica de triagens visuais nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), visando à identificação precoce de alterações visuais, incluindo casos de deficiência visual e visão monocular. Recomenda-se também a redução do tempo de espera para consultas especializadas e exames complementares, garantindo fluxos de encaminhamento mais ágeis para serviços de média e alta complexidade quando necessário;
10. Propõe-se a ampliação da oferta, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), de recursos ópticos e tecnologias assistivas destinadas às pessoas com deficiência visual, incluindo aquelas com visão monocular. Entre esses recursos destacam-se: óculos especiais, lupas ópticas e eletrônicas, para usuários e profissionais, com filtros de contraste e outros

dispositivos que auxiliem na leitura e nas atividades da vida diária. Sugere-se também a criação de programas de orientação e apoio para o uso dessas tecnologias, promovendo maior autonomia e qualidade de vida;

11. Propõe-se o fortalecimento dos serviços de reabilitação visual existentes, com destaque para os Centros Especializados em Reabilitação (CER), garantindo atendimento multiprofissional às pessoas com deficiência visual. Recomenda-se a oferta de acompanhamento com profissionais como oftalmologistas, terapeutas ocupacionais, psicólogos e assistentes sociais, além de atividades voltadas à orientação e mobilidade, adaptação às atividades de leitura e uso de tecnologias assistivas, promovendo inclusão social e funcional;
12. Propõe-se a criação de política nacional de inserção da informação de deficiência irreversíveis permanentes na carteira nacional de identidade, dispensando a necessidade de renovação periódica dos laudos;
13. Propõe-se a criação de ambulatorios de serviços de referências para diagnósticos, acompanhamento e atendimento multidisciplinar para pacientes com fibromialgias e doenças raras, com equipe composta por Reumatologia, Fisioterapia, Psicologia e Assistência social, assim garantido incluindo tratamento fisioterápico, apoio psicológico, terapia ocupacional e manejo da dor;
14. Propõe-se o fortalecimento do acompanhamento domiciliar de pessoas com deficiência (PCDs);
15. Propõe-se a criação de fluxos prioritários de atendimentos para pessoas com deficiência (PCDs) na rede municipal;
16. Propõe-se implementação de sistema de agendamento on-line;
17. Propõe-se que seja ampliada a reabilitação de PCD em todos os níveis, incluindo ECOTERAPIA;
18. Propõe-se a criação um mecanismo de acompanhamento das propostas aprovadas na conferência, com a apresentação de resultados pelo Conselho Municipal de Saúde;
19. Propõe-se implantar e fortalecer a linha de cuidado integral à pessoas com deficiência na rede municipal de saúde, garantindo acesso oportuno aos serviços de reabilitação multiprofissional, acessibilidade física e comunicação nas unidades de saúde, prioridade no atendimento, integração entre Atenção Primária, serviços especializados e demais políticas públicas;
20. Propõe-se a criação de protocolos municipal às famílias quando houver diagnóstico de surdez em bebês, com acompanhamento multiprofissional e psicológico, e oferta de informações sobre Libras e Implante Coclear (IC), garantindo parceria obrigatória com associações de surdos, incluindo pessoas surdas sinalizantes e oralizadas;
21. Propõe-se a adequação das unidades de saúde para garantir acessibilidade às pessoas com deficiência visual, por meio da implantação de sinalização adequada com alto contraste e braille, instalação de piso tátil (que deve ser colocado de forma uniforme), rampas e melhoria das condições de iluminação dos ambientes. Essas medidas visam facilitar a

orientação e a mobilidade dentro dos serviços de saúde, promovendo maior autonomia e segurança para os usuários;

22. Propõe-se a realização de campanhas educativas permanentes voltadas à promoção da saúde ocular e à prevenção de doenças que possam causar deficiência visual. As ações devem incentivar a realização de exames oftalmológicos periódicos, informar sobre fatores de risco e orientar a população sobre os direitos e serviços disponíveis para pessoas com deficiência visual no âmbito do SUS;
23. Propõe-se o fortalecimento das políticas públicas voltadas às pessoas com visão monocular, garantindo seu reconhecimento dentro das políticas de atenção à pessoa com deficiência. Recomenda-se assegurar o acesso dessas pessoas aos serviços de reabilitação, acompanhamento psicossocial e demais programas de inclusão social e de saúde, contribuindo para a redução de barreiras e para a promoção da equidade no acesso aos serviços públicos;
24. Propõe-se a inclusão do exame Angiotomografia das Coronárias, que atualmente não é realizado pelo SUS e no particular fica em torno de R\$ 2 a 3 mil reais;
25. Propõe-se implementar assentos preferenciais de espera para atendimentos nas unidades de saúde, CRAS, e demais locais credenciados pelo SUS;

GRANDE RENASCENÇA

1. **Descentralização dos prestadores de serviços para realização de exames e atendimentos especializados**, de modo que esses serviços sejam ofertados em locais mais próximos dos usuários utilizando como parâmetro para agendamento via sistema a Unidade de Saúde de referência do usuário, facilitando o acesso da população e reduzindo deslocamentos para outras regiões do município, diminuindo também o absenteísmo.
2. **Construção das UBS Violeta, Alto São João e Alcides Rabelo**, com o objetivo de ampliar a cobertura da Atenção Primária à Saúde, melhorar a estrutura de atendimento e fortalecer o acesso da população aos serviços de saúde nos respectivos territórios.
3. **Construção de mais uma UBS**, visando a **descentralização da UBS Planalto**, de modo a ampliar o acesso aos serviços de saúde para a população residente nos bairros **JK, Universitário e Jardim Niemeyer**. A proposta tem como objetivo reduzir a sobrecarga da Unidade atual, facilitar o acesso da população aos atendimentos da Atenção Primária à Saúde e fortalecer a assistência no território.
4. **Ampliação do número de fisioterapeutas nas UBS**, com o objetivo de reduzir o tempo de espera para atendimento, ampliar o acesso da população aos serviços de reabilitação e fortalecer o cuidado integral ofertado na Atenção Primária à Saúde.
5. **Fortalecimento da segurança nas Unidades Básicas de Saúde (UBS)**, por meio da implantação de câmeras de monitoramento e da contratação de profissionais de segurança, tanto no período diurno quanto no noturno. A proposta visa promover maior proteção aos usuários, profissionais e ao patrimônio público, proporcionando um

ambiente mais seguro para a realização dos atendimentos e das atividades de saúde. Reforça-se, ainda, a necessidade de monitoramento constante nas UBS da região do Planalto, considerando episódios recorrentes de arrombamentos, invasões e furtos, especialmente nas UBS Planalto I e III.

6. **Implementar a integração dos sistemas de regulação municipal com o Cartão Nacional de Saúde e o Aplicativo “Meu SUS Digital”**, permitindo o agendamento de consultas, acompanhamento de filas e recebimento de orientações diretamente pelo usuário, visando transparência e agilidade no fluxo das ESF's. Trazendo consequentemente economia pela diminuição do absenteísmo nas consultas e/ou agendamento de exames.
7. **Implantação de uma sala de vacina na UBS Violeta**, assegurando que a população tenha acesso facilitado às ações de imunização.
8. **Inclusão de profissional nutricionista nas UBS Violeta, Walquíria Pereira, Planalto I, II e III, Renascença, Tancredo Neves, Monte Sião e Alcides Rabelo**, fortalecendo as ações de promoção da saúde, prevenção de doenças e acompanhamento nutricional da comunidade.
9. **Ampliação do número de psicólogos na rede**, considerando que atualmente há apenas uma psicóloga responsável por três ou mais Unidades de Saúde da Família (USF), o que dificulta o atendimento adequado à demanda da população.
10. **Garantia de permanência do profissional da farmácia na UBS Violeta**, evitando o remanejamento frequente para outras farmácias, situação que tem causado períodos de desassistência no serviço farmacêutico da unidade.
11. **Ampliação da Unidade de Saúde da Família Vilage do Lago**, visando o aumento do número de consultórios, com o objetivo de ampliar a capacidade de atendimento, melhorar a organização dos serviços e garantir maior acesso da população às consultas e demais ações da Atenção Primária à Saúde.
12. **Investimento na ampliação e fixação de profissionais na rede de saúde, especialmente na área de saúde mental**, com a ampliação do número de psicólogos e médicos psiquiatras com garantia de que cada equipe de Saúde da Família possa contar com profissionais disponíveis de forma contínua ao longo da semana, evitando redistribuições frequentes entre diferentes UBS, o que compromete a continuidade e a qualidade do cuidado, além de reduzir o tempo de espera para atendimento especializado.
13. **Saneamento do esgoto a céu aberto na região do Vilage do Lago** (rua Treze, Vilage do Lago) considerando os riscos à saúde pública e à qualidade de vida da população, solicitando providências para que o problema seja solucionado por meio de ações de infraestrutura e saneamento básico no território.
14. **Retomada e conclusão da construção da sede própria da UBS Jaraguá**, cuja obra encontra-se embargada.
15. **Ampliação da equipe de profissionais da UBS Jaraguá**, com a inclusão de profissionais de **zeladoria e auxiliares administrativos**, a fim de garantir melhores condições de funcionamento e organização dos serviços.

16. **Reforma estrutural completa da UBS Planalto**, que se encontra há mais de 15 anos sem passar por reformas significativas. A requalificação do espaço é essencial para garantir um ambiente adequado, seguro e acolhedor para usuários e trabalhadores da saúde.
17. **Ampliação do número de capacitações voltadas ao acolhimento para os profissionais de saúde das UBS**, com o objetivo de qualificar o atendimento prestado aos usuários, fortalecer a escuta qualificada e promover um atendimento mais humanizado no âmbito da Atenção Primária à Saúde.
18. **Fortalecimento da fiscalização dos prestadores de serviços de saúde**, abrangendo tanto a qualidade dos atendimentos quanto o correto preenchimento de guias, receitas e formulários padronizados. A proposta visa reduzir erros recorrentes nesses documentos, que têm gerado retrabalho para os servidores das UBS, além de contribuir para maior organização, agilidade e eficiência nos fluxos de atendimento.
19. **Disponibilização de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) para as microáreas descobertas das USF's Ipê Branco, Ipê Amarelo, Planalto, Alcides Rabelo, Lírio**, com o objetivo de garantir a cobertura territorial adequada, fortalecer as ações de promoção e prevenção em saúde e assegurar o acompanhamento das famílias pelas equipes da Estratégia Saúde da Família.
20. **Ampliação do acesso à assistência farmacêutica para usuários atendidos na rede privada**, permitindo a dispensação de medicamentos pela rede pública nesses casos. A proposta visa reduzir a sobrecarga nas Unidades Básicas de Saúde, uma vez que muitos usuários retornam às unidades apenas para obter nova prescrição, além de garantir o princípio da integralidade no cuidado em saúde.
21. **Implementação das equipes de Saúde Bucal (eSB) das USF Cerejeira e Jasmim**, considerando que as UBS Planalto II e Renascença já dispõem de espaço físico destinado ao consultório odontológico das equipes. A UBS Planalto não possui cadeira odontológica, ao contrário da UBS Renascença que já possui cadeira instalada.
22. **Implantação da farmácia na UBS Planalto II**, considerando que a Unidade já dispõe de espaço físico destinado a esse serviço, porém ainda não se encontra devidamente implementado e em funcionamento.
23. **Ampliação e garantia do tratamento completo em saúde bucal na Rede de Atenção**, contemplando procedimentos que assegurem a integralidade do cuidado. Destaca-se a necessidade de acesso a tratamentos endodônticos, associados à **reabilitação protética**, como a prótese fixa (coroa dentária), implantes dentários, aparelhos ortodônticos, tratamento da Disfunção Temporomandibular (DTM), possibilitando a recuperação funcional e estética dos usuários.
24. **Ampliar a quantidade de Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs)**, de forma a descentralizar e expandir o acesso da população a serviços odontológicos especializados, como endodontia, periodontia, cirurgias orais e reabilitação protética.
25. **Melhora na oferta e disponibilização de radiografias odontológicas (em todas as UBS)**, fundamentais para o diagnóstico adequado, planejamento e acompanhamento dos tratamentos.

26. **Fortalecimento e ampliação dos grupos de humanização** das UBS, promovendo mais espaços de discussão, capacitação e articulação dentro da Secretaria Municipal de Saúde, valorizando o acolhimento, o respeito e a escuta ativa dos usuários, além de apoiar os profissionais na construção de um ambiente de trabalho mais colaborativo e empático.
27. **Inclusão, com financiamento tripartite, de profissional fisioterapeuta e profissional de educação física em cada Unidade Básica de Saúde**, com o objetivo de ampliar as ações de promoção, prevenção e reabilitação da saúde.
28. **Maior oferta de plantões noturnos nas Unidades de Saúde da Família**, com prioridade para a região do **Grande Renascença**, considerando a necessidade de atendimento em horários fora do expediente regular.
29. **Ampliação da construção de CAPS** na região do Grande Renascença, estruturado para oferecer atendimento multidisciplinar e humanizado.
30. **Realização de auditoria nos resultados de exames laboratoriais e de imagem**, considerando que alguns resultados têm sido considerados duvidosos e questionados por profissionais médicos. A proposta sugere a criação de uma junta técnica/médica para avaliação desses casos, com o objetivo de indicar clínicas e/ou laboratórios que apresentem maior confiabilidade e credibilidade, evitando a necessidade de repetição de exames e garantindo maior segurança e qualidade no diagnóstico dos usuários.
31. **Implantação de estratégias de busca ativa** com o objetivo de **melhorar a oferta de acolhimento e atenção aos usuários LGBTQUIAPN+**, assegurando que tenham acesso aos serviços de saúde de forma integral, humanizada e multiprofissional.
32. **Instituição de um programa de treinamento anual** para todos os funcionários da Prefeitura Municipal, estruturado para atualizar competências técnicas, promover o acolhimento humanizado e capacitar as equipes para o uso de novas tecnologias. Simultaneamente, a proposta prevê a realização de um diagnóstico técnico detalhado para identificar áreas de vazio assistencial e alta densidade demográfica, servindo de base para o planejamento e a construção de novas Unidades Básicas de Saúde.
33. **Realização de pesquisa de campo junto às Unidades Básicas de Saúde (UBS)** para levantamento das ausências e necessidades de profissionais nas equipes. A partir desse diagnóstico, propõe-se o planejamento e a realização de concurso público, visando suprir as demandas identificadas e garantir a permanência e valorização de profissionais que já atuam há longa data nas unidades, fortalecendo a continuidade do cuidado e a organização dos serviços de saúde, prevendo ainda a contagem de tempo de serviço como critério de valorização no processo.

GRANDE SANTOS REIS

- 1) Aumentar a quantidade de Profissionais Administrativos para trabalhar/ contribuir na absorção de demandas inclusive na recepção; necessidade também de

aumentar mais ACS nas equipes da região. A ESF Antonio Narcisio, necessita de uma sede própria, pois hoje se encontram em casa alugada, uma vez que a população tem em sua maioria Idosos, e a construção da ESF Jardim Brasil necessita que essa sede seja entre os bairros Amazonas e Jardim Brasil, para abranger e contemplar de maneira por igual as duas populações.

- 2) **Finalização da construção da ESF Hibisco** que não tem unidade própria no Bairro Castelo Branco, para melhorar o acesso a essa população.
- 3) A maior necessidade hoje é **aumentar o número de profissionais ACS**, uma vez que aumentou o território e necessita de divisão para melhor acompanhamento dos pacientes, com qualidade e excelência. Mesmo com sede própria, algumas unidades necessitam construção de mais salas, uma vez que tem polos Residência Médica e recebem diversos acadêmicos, de diversas categorias. Inclusive na Unidade Conjunto Vitória e Cidade Industrial.
- 4) Usar o Espaço social, em bairros/ territórios distantes servindo como ponto de apoio para melhorar o acesso a essa população. Também necessita de disponibilização de mais computadores e Tablet para uso dos ACS; Também necessita de cadeiras e mesas, ambientes mais apropriados para o trabalho dos ACS nas unidades.
- 5) Regionalização dos atendimentos e tratamentos, melhorando o acesso principalmente da população da região do Santos Reis - articulando melhor os parceiros/ prestadores da
- 6) região.
- 7) Disponibilização de Unidade móvel de segurança pública próximo às unidades do Eldorado e Castelo Branco. Disponibilidade de Fisioterapia individual para cada CID em locais próximos das unidades de saúde.
- 8) Atendimento descentralizado e intersetorial com multiprofissionais para o acompanhamento da mulher com fibromialgia. Disponibilidade de especialistas e prioridade na fila de espera. Deve haver divulgação pois tem profissionais da rede que desconhecem fluxos.
- 9) Disponibilizar medicamentos para pacientes com Fibromialgia, autismo e TDAH, de maneira mais acessível.
- 10) Ampliação do serviço de transporte sanitário para PCDs em deslocamento para exames de média e alta complexidade, consultas W e cirurgias.
- 11) Adaptações em unidades de saúde de banheiros e bebedouros para PNE e PCDs
- 12) Exames laboratoriais por regionalização de exames/ consultas/ acompanhamentos
- 13) Quadra de futebol gratuita, na região do grande Eldorado, com profissionais (treinados) para minimizar a vulnerabilidade social das crianças e jovens da região.
- 14) Ampliação do serviço de transporte sanitário para PCDs em deslocamento para exames de média e alta complexidade, consultas W e cirurgias.
- 15) Sede própria para todas as unidades de saúde com acessibilidade estrutura que comporte os ACS e acadêmicos.
- 16) Capacitação para servidores para o adequado encaminhamentos para procedimentos/cirurgia bariátrica, bem como atenção multiprofissional pós-procedimento.
- 17) Segurança com presença de guardas municipais e militares para comunidade do grande Eldorado.
- 18) Solicita adequações nas instalações dos banheiros das unidades para pacientes com necessidades especiais (PCDs).
- 19) Cobertura física das unidades nos locais de espera do paciente, principalmente em época de chuvas.
- 20) Revisão da fila única para agendamentos de exames e especialidades.

- 21) Revisão das ações e ampliar as ações da Vigilância sanitária em relação a fiscalização de alimentos;
- 22) Disponibilização e acompanhamentos adequados das ações e oferta de equipamentos referente ao Órtese e Prótese;
- 23) Construção de mais UPAs regionais no município. Em especial para a região do Santos Reis.
- 24) Solicitação de computadores para os servidores e infraestrutura adequada para o trabalho.
- 25) Ampliação de terapia ocupacional nas unidades de saúde para os servidores.
- 26) Suprir recursos humanos para o devido funcionamento e cumprimentos da proposta dos horários do Saúde na Hora nas unidades
- 27) Rever as falhas de funcionamento do sistema Vivver.
- 28) Melhorias no transporte público do município.

GRANDE DELFINO

1. **Propõe-se para reduzir o tempo de espera para atendimentos de fisioterapia**, por meio da atuação integrada entre fisioterapeutas e educadores físicos, das equipes e-multi, com prioridade para casos mais graves, a fim de evitar prejuízos no processo de reabilitação.
2. **Propõe-se promover atividades físicas e exercícios laborais**, adequados às diferentes faixas etárias e níveis de limitação motora, visando à prevenção de agravos e à melhoria da qualidade de vida.
3. **Propõe-se ampliar a realização de visitas domiciliares por fisioterapeutas**, fortalecendo o cuidado contínuo, especialmente para pacientes com mobilidade reduzida ou em processo de reabilitação, e contribuindo para a resolutividade da Atenção Primária.
4. **Propõe-se estabelecer parcerias com instituições de ensino para inserção de acadêmicos de fisioterapia em estágio supervisionado na ESF**, especialmente nos atendimentos domiciliares, utilizando recursos terapêuticos simples e portáteis. A iniciativa visa fortalecer o cuidado, contribuindo para a melhoria da estabilidade física e respiratória dos pacientes, em modelo semelhante ao adotado nos cursos de medicina.
5. **Propõe-se implantar um Hospital Regional de Trauma**, com estrutura adequada para atendimento de urgência e emergência, ampliando a capacidade de resposta da rede de saúde.
6. **Propõe-se ampliar a oferta de grupos terapêuticos**, com foco na melhoria das condições psicológicas e fisiológicas da população, fortalecendo o cuidado integral.

7. **Propõe-se reestruturar e ampliar a UBS Santa Lúcia I**, garantindo espaço adequado para a realização de atividades laborais e ações coletivas de saúde.
8. **Propõe-se ampliar o transporte sanitário**, garantindo maior acesso da população aos serviços de saúde, com organização eficiente da demanda e priorização dos usuários em situação de maior vulnerabilidade.
9. **Propõe-se ampliar os centros especializados**, visando aumentar a capacidade de atendimento e reduzir o tempo de espera para consultas e procedimentos especializados.
10. **Propõe-se ampliar a oferta de odontologia hospitalar**, por meio da contratação de cirurgiões-dentistas, garantindo assistência integral aos pacientes internados.
11. **Propõe-se equipar todas as UBS com aparelhos de radiografias odontológicas adequados**, assegurando condições seguras e resolutivas para o atendimento em saúde bucal.
12. **Propõe-se implantar laboratórios clínicos municipais**, com o objetivo de ampliar o acesso a exames diagnósticos e reduzir o tempo de resposta para os resultados.
13. **Propõe-se aprimorar a regionalização e a logística de distribuição de vagas para exames e consultas**, visando facilitar o acesso da população, otimizar a utilização dos serviços e reduzir o absenteísmo.
14. **Propõe-se agilizar o acesso a exames especializados**, com prioridade para exames críticos, como cardiológicos, radiografias e ultrassonografias, visando diagnóstico oportuno, redução de filas e maior resolutividade da assistência.
15. **Propõe-se disponibilizar veículo próprio com motorista para cada Unidade de Saúde da Família**, destinado ao deslocamento das equipes nas visitas domiciliares e ao apoio no transporte de usuários da área adscrita, mediante agendamento, ampliando o acesso e a continuidade do cuidado.
16. **Propõe-se organizar o agendamento da fisioterapia por território**, priorizando o encaminhamento dos pacientes para prestadores mais próximos de suas residências, facilitando o acesso e reduzindo faltas.
17. **Propõe-se implantar e garantir a utilização integrada de um sistema único de prontuário eletrônico no município (PEC)**, abrangendo todos os prestadores de serviços e unidades hospitalares, com acesso em tempo real ao histórico do paciente, promovendo a continuidade e a integralidade do cuidado.
18. **Propõe-se reformar e ampliar os consultórios das UBS Vila Anália II, Lourdes, Vila Sion, Santo Antônio II, e Santa Lúcia**, garantindo melhores condições de trabalho para os profissionais e ampliando a capacidade de atendimento à população.

19. **Propõe-se fortalecer os processos de auditoria dos prestadores de serviços**, assegurando a qualidade da assistência, a adequada utilização dos recursos e a conformidade com os protocolos estabelecidos.
20. **Propõe-se fortalecer a fiscalização e o monitoramento das clínicas prestadoras de serviços ao SUS**, avaliando a qualidade da assistência ofertada, o cumprimento de contratos e protocolos, e a satisfação dos usuários.
21. **Propõe-se implantar equipamentos de raio-X e eletrocardiograma nas Unidades de Saúde**, ampliando o acesso a exames, agilizando o diagnóstico e contribuindo para a redução de filas e da sobrecarga nos serviços especializados.
22. **Propõe-se atualizar os sistemas de informação em saúde local (próprio)**, garantindo dados fidedignos por microárea e reduzindo a necessidade do uso de instrumentos manuais, como as fichas B e C.
23. **Propõe-se ampliar a contratação de psicólogos para as UBS**, fortalecendo o atendimento aos usuários em sofrimento mental e qualificando o cuidado na Atenção Primária.
24. **Propõe-se ampliar e adequar os consultórios das UBS**, visando aumentar a capacidade de atendimento e garantir condições adequadas de trabalho aos profissionais.
25. **Propõe-se fortalecer a fiscalização das UBS quanto às condições ergonômicas de trabalho**, assegurando ambientes adequados, especialmente em recepções e salas de ACS.
26. **Propõe-se ampliar a estrutura física e os recursos humanos dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO)**, aumentando a oferta e a resolutividade dos atendimentos especializados em saúde bucal.
27. **Propõe-se ampliar a oferta de próteses dentárias**, garantindo reabilitação oral, melhoria da qualidade de vida e promoção da saúde bucal da população.
tran
28. **Propõe-se ampliar o apoio e a assistência às crianças com Transtorno do Espectro Autista**, garantindo acesso ao acompanhamento contínuo e aos serviços especializados, promovendo cuidado integral e equitativo.
29. **Propõe-se promover a equidade de direitos entre profissionais efetivos e contratados**, assegurando condições isonômicas de trabalho, incluindo a possibilidade

de redução da carga horária quando exercem as mesmas funções e responsabilidades.

30. **Propõe-se implantar o projeto “Rede Ativa” na Atenção Primária**, integrando práticas de promoção da saúde, prevenção de agravos e cuidado contínuo, fortalecendo a atuação das equipes.
31. **Propõe-se implantar centro ambulatorial de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS)**, com ênfase em abordagens da medicina tradicional chinesa, ampliando as opções terapêuticas ofertadas à população.
32. **Propõe-se adquirir equipamentos próprios para realização de exames especializados**, como endoscopia, mamografia e monitorização ambulatorial (MAPA/Holter), reduzindo a dependência de prestadores externos e ampliando o acesso aos usuários do SUS.
33. **Propõe-se reduzir o tempo de espera para consultas e exames especializados**, por meio da otimização dos fluxos de regulação, ampliação da oferta e melhor gestão das agendas.
34. **Propõe-se capacitar os profissionais das unidades de saúde para o atendimento às Pessoas com Deficiência (PCDs)**, promovendo cuidado inclusivo, humanizado e qualificado.
35. **Propõe-se implantar a coleta de exames laboratoriais nas próprias UBS ou garantir o agendamento imediato após a consulta**, assegurando maior acesso, agilidade no diagnóstico e redução do tempo de espera.
36. **Propõe-se garantir o pagamento de adicional de insalubridade aos profissionais que atuam nas UBS**, incluindo recepcionista, assistentes administrativos, psicólogos, gerentes e apoiadores, conforme avaliação das condições de trabalho e exposição a riscos ocupacionais, em conformidade com a legislação vigente.
37. **Propõe-se estabelecer o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) para os profissionais das UBS**, conforme avaliação técnica das condições de trabalho e em conformidade com a legislação vigente.

GRANDE INDEPENDÊNCIA

1. **Reestruturação das Unidades Básicas de Saúde (UBS):** Substituição de UBS instaladas em imóveis alugados e inadequados por unidades próprias, planejadas e com infraestrutura adequada para garantir qualidade no atendimento à população.
2. **Climatização das UBS:** Implantação de sistemas de climatização em todas as Unidades Básicas de Saúde do Grande Independência assegurando condições adequadas de

trabalho para os profissionais e conforto térmico para os usuários.

3. **Ampliação da estrutura física das UBS:** Adequação do número de consultórios, permitindo o atendimento simultâneo de todos os profissionais da equipe multiprofissional, reduzindo filas e otimizando o acesso.
4. **Melhoria no acesso a exames e consultas especializadas:** Redução do tempo de espera para agendamentos, por meio da ampliação da oferta e da organização dos fluxos assistenciais.
5. **Adequação estrutural da UBS Acácias:** Climatização dos consultórios e demais ambientes, garantindo melhores condições de atendimento e trabalho.
6. **Necessidade de realização de processo seletivo para Agente Comunitário de Saúde para o Grande Independência:** tendo em vista que algumas equipes estão com quantidade insuficiente destes profissionais.
7. **Necessidade de profissionais administrativos na recepção:** Considerando a demanda de atendimento das unidades e as necessidades de melhor organização do fluxo de usuários.
8. **Iluminação no entorno das UBS do grande Independência:** Necessidade de melhoria da iluminação pública no entorno e nas ruas próximas à unidade de saúde, visando maior segurança para profissionais e usuários.
9. **Reorganização da atuação da Residência na UBS Acácias:** Avaliar e realizar a readequação da Residência Multiprofissional na UBS, considerando os impactos na longitudinalidade do cuidado e na continuidade do vínculo entre equipe e usuários, assegurando a qualidade da atenção prestada.
10. **Aumento da oferta Uniformes e protetor solar adequados ao trabalho,** entre outros itens necessários para a proteção dos profissionais.
11. **Descentralização do agendamento de exames laboratoriais:** Implantação de pontos de apoio para coleta e/ou agendamento em locais mais próximos aos territórios, facilitando o acesso da população e reduzindo deslocamentos.
12. **Revisão e ampliação da lista de exames ofertados:** Incluir exames essenciais como ultrassom de parede abdominal, ecocardiograma fetal e ultrassom morfológico, garantindo que pacientes com dificuldades de acesso particular possam realizar os procedimentos, evitando atrasos em diagnósticos e cirurgias, e promovendo maior equidade no atendimento pelo SUS.
13. **Garantia de manutenção dos aparelhos de ar-condicionado nas UBS:** Contratar prestadores de serviços especializados para realizar manutenção preventiva e corretiva, assegurando o funcionamento adequado dos equipamentos e melhores condições de

trabalho e conforto para profissionais e usuários.

14. **Fortalecimento das equipes e-Multi na Atenção Primária:** Ampliar a quantidade de profissionais de educação física, psicólogos, fisioterapeutas e nutricionistas nas equipes de Saúde da Família.
15. **Implantação de espaço adequado para resíduos de serviços de saúde na UBS Independência II:** Construir áreas específicas para o armazenamento de resíduos de serviços de saúde (lixo especial), em conformidade com as normas sanitárias vigentes.
16. **Redivisão da equipe de Saúde da Família Independência II:** Reavaliar a divisão da equipe para melhor distribuição da carga de trabalho, cobertura territorial adequada e otimização do atendimento à população, garantindo maior eficiência e qualidade nos serviços prestados.
17. **Saneamento básico nas proximidades da UBS Independência II:** Implementar ações urgentes para eliminação de esgoto a céu aberto, nas Rua República do Peru, Bolívia e Colômbia, com a implantação e/ou adequação da rede de coleta e tratamento de esgoto, visando à melhoria das condições sanitárias, prevenção de doenças e promoção da saúde da população local.
18. **Criação de sala de vacina na UBS Independência II.**
19. **Aquisição de mais computadores para as UBS da região do grande Independência:** Disponibilizar equipamentos adicionais para melhorar o registro de informações, o trabalho dos profissionais e a organização dos atendimentos.
20. **Ampliação do acesso à vacinação antirrábica na região do Grande Independência:** Descentralizar a oferta da vacina antirrábica, com disponibilização em pontos estratégicos mais próximos aos territórios do Grande Independência facilitando o acesso da população.
21. **Construção de UBS no bairro Novo Primavera:** Implantar uma nova Unidade própria, e com infraestrutura adequada para atender ao crescimento populacional do bairro.
22. **Implantação de consultório odontológico e equipe de Saúde Bucal na UBS Jardim Primavera:** Criar mais uma equipe de Saúde Bucal para ampliar a cobertura, reduzir filas de atendimento e garantir acesso qualificado aos cuidados de saúde bucal da população.
23. **Implantação de Academia de Saúde no bairro Jardim Primavera:** Criar um espaço estruturado para atividades físicas, promoção da saúde e prevenção de doenças, oferecendo à comunidade oportunidades de exercícios orientados e programas de bem-estar.

24. **Informatização de chamada eletrônica nas UBSs:** Implantar sistema de chamada eletrônica de pacientes via telas de TV, organizando o fluxo de atendimento, reduzindo filas e otimizando a gestão do serviço de saúde.
25. **Retorno dos serviços de farmácia e sala de vacina ao horário estendido na UBS Jardim Primavera, Acácias e Independência I e implementação do horário estendido na odontologia na UBS Jardim Primavera,** visando garantir maior acesso da população aos medicamentos, imunização e tratamentos odontológicos, especialmente para quem não consegue se deslocar às UBSs no período convencional.
26. **Melhoria no agendamento de exames e consultas especializadas:** Reduzir o tempo de espera para exames laboratoriais/diagnósticos e consultas especializadas, incluindo fisioterapia, por meio de organização de fluxos, ampliação da oferta e otimização do agendamento, garantindo maior acesso e resolutividade para a população.
27. **Reforma da UBS Esplanada:** Reforma e ampliação da infraestrutura da Unidade antiga e com estrutura insuficiente, garantindo suporte para múltiplos profissionais, atendimento de plantão noturno, salas de vacina e farmácia, atendimento pediátrico, além da implantação de climatização para maior conforto e eficiência no atendimento.
28. **Construção de estrutura física própria para UBS do Interlagos:** Substituir a atual casa alugada por uma UBS planejada e adequada, oferecendo melhores condições de trabalho para a equipe e atendimento de qualidade à população da região.
29. **Reforço do quadro de profissionais da UBS Esplanada III:** Agentes Comunitários de Saúde (ACS), equipe administrativa e substituição temporária da técnica de enfermagem, uma vez que essa sairá de licença maternidade em 19/03, garantindo continuidade e qualidade no atendimento.
30. **Melhoria da estrutura física da UBS Nova Suíça:** Ampliar a Unidade para oferecer condições adequadas de trabalho, atendimento à população e recepção de acadêmicos para estágios e atividades de ensino.
31. **Reavaliação do programa Saúde na Hora na UBS Nova Suíça:** Propor a retirada do programa, considerando sua ineficácia devido à ausência de profissionais nos horários estendidos, baixa procura após as 18h e questões de segurança para as profissionais, especialmente, mulheres. Priorizar alternativas que garantam atendimento contínuo, seguro e de qualidade à população.
32. **Aumento do número de gerentes para as UBS:** Aumentar o quadro de gerentes, de modo que cada profissional assuma apenas uma unidade, em vez de múltiplas equipes, garantindo acompanhamento mais próximo, melhor coordenação das equipes e maior eficiência na gestão dos serviços de saúde.

33. **Reavaliação do sistema de avaliação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS):** Ajustar os critérios de avaliação, considerando o número de famílias acompanhadas em vez do número de indivíduos.
34. **Melhoria da estrutura física da UBS Independência I:** Adequar e ampliar a Unidade, incluindo instalação de climatização e ventilação adequadas, garantindo conforto para profissionais e usuários e melhores condições de atendimento à população.
35. **Instalação de bebedouros de qualidade nas UBS região do Grande Independência:** Disponibilizar pontos de hidratação adequados para usuários e profissionais, garantindo acesso à água potável e promovendo melhores condições de conforto e saúde na unidade.
36. **Reorganização das equipes na UBS Independência I:** Diante da superlotação, propor que a quarta equipe seja realocada para outra estrutura física, visando melhorar o fluxo de atendimento, reduzir filas e garantir qualidade no serviço prestado à população.
37. **Organização do tráfego no entorno da UBS Independência I:** Implantar sentido único (mão única) na via onde está localizada a unidade, visando melhorar a mobilidade, aumentar a segurança de pedestres e usuários e facilitar o acesso aos serviços de saúde.
38. **Implantação de cadeira odontológica e ampliação da equipe de Saúde Bucal na UBS Independência I:** Disponibilizar equipamento adequado e reforçar a equipe de odontologia, garantindo atendimento de qualidade, redução de filas e maior cobertura de saúde bucal para a população.
39. **Melhoria na segurança nas UBS com horário estendido:** Melhorar medidas de segurança adequadas, como vigilância, controle de acesso e infraestrutura protegida, garantindo a proteção de profissionais e usuários durante o funcionamento em horários estendidos.
40. **Ampliação das práticas integrativas na Atenção Primária,** incluindo a implantação de um Centro voltado para a oferta de práticas integrativas de saúde para a região do Grande Independência promovendo cuidado integral, prevenção de doenças e melhoria da qualidade de vida da população.
41. **Disponibilização de serviços de radiologia odontológica e farmácia na UPA, inclusive aos finais de semana,** garantindo diagnóstico e tratamento adequados, além de acesso contínuo a medicamentos para a população atendida.
42. **Construção de sede própria para a UBS Carmelo I:** Substituir o imóvel alugado por uma Unidade própria, planejada e com infraestrutura adequada para atendimento da população e trabalho em equipe.
43. **Melhoria do consultório odontológico da UBS Carmelo I:** Garantir espaço adequado, ventilado e equipado, substituindo o atual cômodo comercial que não atende às necessidades do atendimento odontológico.

44. **Adequação da estrutura interna e equipamentos da UBS Carmelo I:** Implantar sala de espera, aumentar o número de computadores e tablets funcionais para os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), garantindo melhor organização e suporte ao trabalho da equipe.
45. **Implantação de serviços essenciais na UBS Carmelo I:** Disponibilizar sala de vacina e farmácia, garantindo acesso mais rápido e eficiente aos serviços de saúde.
46. **Otimização dos agendamentos de exames, consultas especializadas e outros serviços:** Estabelecer prazos maiores para avisar os pacientes sobre os agendamentos, evitando avisos de última hora e melhorando a comunicação com a população.
47. **Aumento da oferta de consultas especializadas,** como hematologia e reumatologia, garantindo maior acesso da população a diagnósticos e tratamentos especializados de forma ágil e eficiente.
48. **Higienização das filas de demanda reprimida:** As equipes de Saúde da Família devem realizar revisão e correção periódica das filas no sistema, otimizando a distribuição de vagas, e garantindo maior controle, transparência e eficiência no acompanhamento das demandas de atendimento. Sugere-se que ocorra de forma automática: quando o paciente for identificado com mudança de endereço/município ou óbito, sair automaticamente da lista de demanda reprimida.
49. **Descentralização do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) para a região do Grande Independência:** Implantar unidades de Média Complexidade em saúde bucal mais próximas à população, reduzindo deslocamentos, filas de espera.
50. **Infraestrutura da Academia de Saúde Independência:** Disponibilizar acesso à internet na academia, permitindo que os profissionais realizem o lançamento da produção diretamente no local, evitando deslocamentos desnecessários até a UBS; bebedouro para os usuários e profissionais, reforma da academia de Saúde, como instalação de piso adequado, conserto de infiltrações e pintura.
51. **Tablet do ACS:** Melhorar a informação dos marcadores de condições clínicas dos pacientes. Ex: Já aparece Gestante, HAS e DM. Querem que apareça: Deficiências e outras condições.
52. Implementar a informatização do SISAB.

GRANDE MAJOR PRATES

1. **Reestruturação das Unidades Básicas de Saúde (UBS):** Substituição de UBS instaladas em imóveis alugados e inadequados por unidades próprias, planejadas e com

infraestrutura adequada para garantir qualidade no atendimento à população. Como por exemplo as unidades do Safira, Diamante, Turmalina, Marfim e Esmeralda.

2. **Implantação de uma sala de vacina nas UBSs Safira e Esmeralda**, assegurando que a população tenha acesso facilitado às ações de imunização.
3. **Implantação de uma farmácia nas UBSs Safira e Esmeralda**, visando garantir a descentralização da assistência e o acesso facilitado da população aos medicamentos e insumos essenciais.
4. **Implantação do Centro Municipal de Análises Clínicas**, mediante o aporte de recursos de financiamento tripartite. O objetivo é fortalecer a rede de apoio diagnóstico, assegurando celeridade no processamento de exames e maior resolutividade na atenção primária.
5. **Criação do serviço de transporte sanitário gratuito** dedicado ao atendimento de pacientes com destino a rede de atendimento hospitalar, com estabelecimento de horários fixos de ida e volta, objetivando otimizar o fluxo de pacientes, garantindo a pontualidade nos atendimentos e minimizando as faltas por dificuldades de deslocamento.
6. **Expansão do credenciamento de Equipes de Saúde Bucal para atingir 100% das equipes de Saúde da Família**. O objetivo é mitigar a alta demanda reprimida e assegurar que o atendimento odontológico seja realizado na unidade de referência do próprio usuário, otimizando o fluxo assistencial e a resolutividade na Atenção Primária.
7. **Implementação da especialidade de Odontopediatria nos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) do município**. A medida é fundamental para assegurar a integralidade da assistência à saúde bucal infantil, garantindo que casos de maior complexidade que extrapolam a competência da Atenção Primária recebam atendimento especializado e humanizado dentro da rede pública.
8. **Melhoria na oferta e disponibilização de radiografias odontológicas (em todas as UBS)**, fundamentais para o diagnóstico adequado, planejamento e acompanhamento dos tratamentos.
9. **Adequação da infraestrutura das Unidades Básicas de Saúde (UBS)**, com ênfase na melhoria dos banheiros destinados aos usuários. Observa-se que, em muitas unidades, esses espaços apresentam condições inadequadas de uso, comprometendo o conforto, a higiene, a acessibilidade e a dignidade dos cidadãos atendidos.
10. **Contratação de assistentes administrativos para compor o quadro de funcionários das Unidades Básicas de Saúde (UBS)**. A ausência desses profissionais tem acarretado sobrecarga administrativa e o consequente desvio de função dos demais membros da equipe. A necessidade de escalas rotativas para suprir demandas de recepção compromete o tempo dedicado às atividades finalísticas de assistência, gerando prejuízos à continuidade do cuidado.

11. **Ampliação da oferta de consultas e procedimentos odontológicos especializados**, com foco na redução da demanda reprimida em Endodontia e Cirurgia Bucomaxilofacial. A medida visa mitigar o tempo de espera na regulação e garantir a resolutividade dos casos de média complexidade, evitando o agravamento de quadros clínicos e perdas dentárias evitáveis.
12. **Ampliação e diversificação do rol de insumos odontológicos para a Atenção Primária**, com a inclusão de materiais como resina flow e pasta CTZ. A medida visa fortalecer a resolutividade clínica nas Unidades Básicas de Saúde, permitindo a realização de tratamentos endodônticos em dentes decíduos no próprio território.
13. **Fortalecimento da atuação do Conselho Tutelar por meio da contratação de profissionais especializados** para apoio técnico e administrativo. O objetivo é elevar o rigor técnico das intervenções e assegurar que as medidas aplicadas estejam em plena conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), otimizando a articulação com a rede de garantias de direitos.
14. **Garantir locais de trabalho salubres, com climatização adequada**, uma vez que o uso de equipamentos de proteção individual deixa o trabalhador em condições de superaquecimento para o desempenho de suas funções.
15. **Padronização e disponibilização de kits cirúrgicos estéreis e descartáveis para a rede municipal de saúde bucal**. A medida visa garantir o rigoroso cumprimento das normas de biossegurança, minimizando riscos de infecção cruzada e assegurando a integridade biológica dos usuários e profissionais durante procedimentos invasivos.
16. **Instituição de fluxo preferencial para a liberação e processamento de exames laboratoriais e de imagem destinados ao público infantil**. A medida fundamenta-se no princípio da prioridade absoluta estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), visando à celeridade diagnóstica e a redução do tempo de espera para o início de protocolos terapêuticos em pacientes pediátricos.
17. **Instituição do programa de assistência odontológica no ambiente escolar**, integrando as ações da Atenção Primária à Educação. A medida é estratégica para garantir o acompanhamento longitudinal dos estudantes, permitindo a realização de levantamentos epidemiológicos, atendimentos clínicos, atividades de educação em saúde e intervenções preventivas coletivas. A importância reside na redução drástica dos índices de cárie e doenças periodontais, fundamentais para o desenvolvimento saudável e a qualidade de vida dos escolares.
18. **Ampliação das equipes E-multi para todas as unidades de saúde**. A ampliação das equipes E-Multi contribuirá para a redução da sobrecarga dos profissionais, melhoria do acesso aos serviços especializados e maior resolutividade na Atenção Primária, impactando positivamente na qualidade do atendimento e nos indicadores de saúde da população.
19. **Implementação de um Programa de Educação Permanente em Legislação e Normativas do SUS, voltado para gerentes de unidades e assistentes administrativos**. A proposta é fundamental para assegurar a conformidade legal dos atos administrativos e o fortalecimento do controle social. A importância reside na mitigação de riscos jurídicos e na garantia de que a gestão local esteja alinhada às diretrizes da descentralização e da universalidade do sistema.

20. **Regularizar o vínculo empregatício dos trabalhadores do SUS.** Substituir vínculos precários por formas de contratação regulares, conforme a legislação vigente, assegurando direitos trabalhistas e previdenciários aos profissionais.
21. **Otimização do fluxo de processamento e entrega de resultados de exames citopatológicos (PCCU).** Embora o acesso à coleta nas UBS esteja regularizado, o tempo de espera para o laudo excede os seis meses, comprometendo a oportunidade diagnóstica. Esse atraso gera a evasão de usuárias para a rede privada, impactando negativamente os indicadores pactuados e a continuidade do rastreamento no SUS
22. **Construção de mais Centros de Especialidades Odontológicas,** para atender as demandas da população, a fim de reduzir as filas de espera e garantir maior acesso a procedimentos como endodontia, periodontia, cirurgia oral menor, atendimento a pacientes com necessidades especiais, entre outros.
23. **Fortalecimento da política de contratualização com prestadores de serviços, assegurando tabelas de remuneração atualizadas e mecanismos rigorosos de avaliação de desempenho.** A implementação de indicadores de qualidade e auditorias periódicas permitirá identificar gargalos na assistência, garantindo que o financiamento adequado se traduza em uma melhor experiência para o paciente e em maior eficiência na rede municipal.
24. **Implementar melhorias no transporte sanitário do município,** a fim de melhorar o acesso da população aos serviços de saúde, reduzir faltas em atendimentos por dificuldades de deslocamento e garantir maior eficiência e qualidade no transporte sanitário municipal.
25. **Criação ou adequação de espaços reservados, confortáveis e climatizados,** destinados ao repouso dos profissionais durante os intervalos de trabalho para os profissionais que trabalham em horário saúde na hora.
26. **Instituição da Linha de Cuidado em cuidados paliativos, com financiamento tripartite,** integrada aos diferentes níveis de atenção do SUS. A proposta visa garantir a assistência integral e humanizada a pacientes com doenças graves e progressivas, com ênfase na linha de cuidado oncológica. O foco reside no controle impecável de sintomas com equipe transdisciplinar assegurando a dignidade e a qualidade de vida tanto do usuário quanto de seu núcleo familiar.
27. **Implementação da Política Nacional de Atenção à Oncologia Pediátrica,** (Lei nº 14.308/21) que visa aumentar a sobrevida e reduzir a mortalidade e o abandono de tratamento do câncer em crianças e adolescentes. Priorizando o diagnóstico precoce, tratamento ágil no SUS.
28. **Estruturação e padronização do aporte de recursos psicopedagógicos e materiais lúdico-terapêuticos nos consultórios de Psicologia da rede municipal,** com o objetivo de qualificar o atendimento, especialmente de crianças, adolescentes e demais públicos que demandam abordagens específicas, garantindo ferramentas adequadas para o manejo de demandas do neurodesenvolvimento e assegurando a resolutividade do cuidado integral.

29. **Ampliar a lista de medicamentos essenciais** ofertados nas farmácias do SUS, considerando as necessidades epidemiológicas locais e as demandas dos serviços de saúde mental.
30. **Adequar os recursos financeiros às reais demandas da população**, garantindo maior oferta de serviços, redução de filas de espera e maior agilidade no acesso aos diagnósticos e tratamentos. Para isso, sugere-se a revisão dos valores de custeio, ampliação dos repasses aos prestadores de serviços e melhoria dos mecanismos de contratualização com a rede conveniada.
31. **Implementação de polos regionais para atendimentos de Fisioterapia e realização de ECG**. A relevância desta reestruturação logística está na redução drástica do absenteísmo. A importância disso é dar dignidade ao paciente, especialmente idosos e pessoas com deficiência, que muitas vezes sofrem com trajetos longos e caros. Aproximar o serviço do cidadão é garantir que ele comece e termine o tratamento, melhorando os indicadores de saúde de toda a cidade.
32. **Instituição de um Programa de Educação Permanente em Estomatoterapia e Tratamento de Feridas**, aliado à padronização e descentralização de coberturas especiais para as Unidades Básicas de Saúde (UBS). A relevância desta medida reside na garantia da integralidade do cuidado no território, permitindo o manejo adequado de lesões complexas, a redução do tempo de cicatrização e a mitigação de riscos de complicações graves e internações evitáveis.
33. **Ampliação e descentralização dos serviços de assistência e dispensação de insumos estratégicos vinculados ao NAJU**. A proposta busca regionalizar a entrega de itens de alto impacto social, como fraldas descartáveis e equipamentos para oxigenoterapia, facilitando o acesso capilarizado no território e mitigando as barreiras geográficas que dificultam a adesão ao cuidado domiciliar.

GRANDE MARACANÃ

1. **Implementar um modelo de gestão assistencial focado na redução do tempo de espera** e na agilização da marcação e realização de consultas, exames especializados e laboratoriais, garantindo o acesso oportuno e equânime da população aos serviços de saúde.
2. **Assegurar a manutenção integral das equipes de saúde** por meio de estratégias de contratação, provimento e reposição ágil, garantindo que o atendimento à população não sofra interrupções por vacâncias, férias ou licenças.
3. **Garantir a disponibilidade ininterrupta de medicamentos do componente básico e especializado nas farmácias da rede municipal**, assegurando que o tratamento prescrito aos usuários não seja interrompido por falhas de suprimento.

4. **Garantir o funcionamento pleno das Unidades de Saúde da Família (USF) e das equipes de Saúde Bucal em dois turnos** (matutino e vespertino) expandindo a capacidade de agendamento e acolhimento da população.
5. **Criação do serviço de transporte sanitário gratuito** dedicado ao atendimento de pacientes com destino a rede de atendimento hospitalar, com estabelecimento de horários fixos de ida e volta, objetivando otimizar o fluxo de pacientes, garantindo a pontualidade nos atendimentos e minimizando as faltas por dificuldades de deslocamento.
6. **Formalizar e fortalecer os Comitês Intersetoriais nos territórios de saúde**, garantindo a articulação entre as políticas públicas locais e a participação ativa da gestão das Unidades Básicas de Saúde (UBS) na resolução de problemas complexos da comunidade.
7. **Implantação de Planos de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS)**, para os profissionais da saúde, promovendo valorização, estabilidade, progressão profissional e melhoria na qualidade dos serviços prestados à população.
8. **Construção de Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)**, com o objetivo de fortalecer o atendimento de urgência e emergência, reduzir a sobrecarga da atenção primária e dos hospitais, e garantir atendimento mais ágil e resolutivo à população.
9. **Ampliação da rede de Centros de Referência de Assistência Social (CRAS)**, garantindo maior cobertura territorial, acesso facilitado aos serviços socioassistenciais e fortalecimento do atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social.
10. **Criação de centro para atendimento de práticas integrativas e complementares**, integrando-as à rede municipal de saúde para oferecer um cuidado multidimensional e humanizado aos usuários.
11. **Implantação de postos de coleta laboratorial nas UBS**, garantindo maior acesso da população a exames, agilizando diagnósticos e reduzindo deslocamentos desnecessários para outros serviços de saúde.
12. **Criação de um Centro Multidisciplinar especializado no atendimento a pessoas com Transtorno do Espectro Autista**, oferecendo suporte integrado nas áreas de saúde, educação e assistência social. Também atuará no apoio às famílias e na inclusão social dos atendidos.
13. **Expansão do credenciamento de Equipes de Saúde Bucal para atingir 100% das equipes de Saúde da Família**. O objetivo é mitigar a alta demanda reprimida e assegurar que o atendimento odontológico seja realizado na unidade de referência do próprio usuário, otimizando o fluxo assistencial e a resolutividade na Atenção Primária.
14. **Ampliação das equipes E-multi para todas as unidades de saúde**. A ampliação das equipes E-Multi contribuirá para a redução da sobrecarga dos profissionais, melhoria do acesso aos serviços especializados e maior resolutividade na Atenção Primária, impactando positivamente na qualidade do atendimento e nos indicadores de saúde da população.

- 15. Fortalecimento da política de contratualização com prestadores de serviços, assegurando tabelas de remuneração atualizadas e mecanismos rigorosos de avaliação de desempenho.** A implementação de indicadores de qualidade e auditorias periódicas permitirá identificar gargalos na assistência, garantindo que o financiamento adequado se traduza em uma melhor experiência para o paciente e em maior eficiência na rede municipal.
- 16. Adequar os recursos financeiros às reais demandas da população,** garantindo maior oferta de serviços, redução de filas de espera e maior agilidade no acesso aos diagnósticos e tratamentos. Para isso, sugere-se a revisão dos valores de custeio, ampliação dos repasses aos prestadores de serviços e melhoria dos mecanismos de contratualização com a rede conveniada.
- 17. Descentralização dos prestadores de serviços para realização de exames e atendimentos especializados,** de modo que esses serviços sejam ofertados em locais mais próximos dos usuários utilizando como parâmetro para agendamento via sistema a Unidade de Saúde de referência do usuário, facilitando o acesso da população e reduzindo deslocamentos para outras regiões do município, diminuindo também o absenteísmo.
- 18. Ampliar o quadro de médicos e profissionais especialistas na rede pública de saúde para suprir a demanda reprimida,** reduzindo o tempo de espera para consultas e exames especializados e garantindo a integralidade do cuidado iniciado na Atenção Primária.
- 19. Realização de processo seletivo para Agentes Comunitários de Saúde (ACS)** com o objetivo de suprir as microáreas descobertas e fortalecer a atenção básica. A iniciativa visa ampliar a cobertura dos serviços de saúde e melhorar o acompanhamento das famílias.
- 20. Prestação de serviços de segurança nas unidades.** Melhorar medidas de segurança adequadas, como vigilância, controle de acesso e infraestrutura protegida, garantindo a proteção de profissionais e usuários.
- 21. Garantir que os servidores da rede municipal de saúde tenham direito ao atendimento clínico, odontológico e preventivo na unidade onde exercem suas funções laborais,** independentemente do seu local de domicílio ou cadastro.
- 22. Implementação de medidas para garantir maior agilidade na manutenção dos equipamentos odontológicos** nas unidades de saúde. A proposta visa reduzir o tempo de inatividade dos aparelhos e assegurar a continuidade dos atendimentos.
- 23. Criação de espaços terapêuticos destinados ao acolhimento e cuidado integral dos usuários.** A iniciativa visa promover o bem-estar físico e emocional por meio de atividades terapêuticas, contribuindo para a humanização dos serviços e fortalecimento do vínculo com a comunidade.

- 24. Implementar um programa de educação permanente, avaliação de competências e padronização dos fluxos de trabalho para os profissionais de Educação Física das equipes e-Multi**, garantindo que as ações executadas na ponta estejam rigorosamente alinhadas às diretrizes da gestão municipal.
- 25. Ampliação da USF São Geraldo II e aumento do número de colaboradores**, garantindo maior capacidade de atendimento, redução da sobrecarga da equipe e melhoria da qualidade dos serviços prestados à comunidade.
- 26. Construir e equipar uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) no bairro São Geraldo II**, visando expandir a cobertura assistencial de urgência e emergência e garantir o atendimento imediato de média complexidade para a região.
- 27. Implementação de cronograma rigoroso de manutenção preventiva e corretiva, com suporte técnico contínuo para os tablets utilizados pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e técnicos**. A proposta inclui a aquisição de novos dispositivos, quando necessário, garantindo a integridade dos dados e a eficiência na coleta de informações no território. Também visa assegurar a continuidade e qualidade das atividades em campo.
- 28. Implantação de serviço de fisioterapia na USF São Geraldo 2**, com o objetivo de ampliar o acesso à reabilitação física para usuários da unidade e regiões próximas. A iniciativa visa promover recuperação funcional, prevenção de agravos e melhoria da qualidade de vida. Também contribuirá para descentralizar o atendimento e reduzir a demanda em outros serviços.
- 29. Fornecimento de protetores solares de qualidade para os Agentes Comunitários de Saúde (ACS)**, visando a proteção contra os efeitos nocivos da exposição solar durante as atividades externas. A iniciativa contribui para a prevenção de doenças de pele e promoção da saúde ocupacional. Também reforça o cuidado com a segurança e bem-estar dos profissionais.
- 30. Aquisição de novas cadeiras odontológicas** para equipar as equipes que ainda não dispõem desse recurso, garantindo condições adequadas de trabalho, ampliando a capacidade de atendimento e promovendo mais conforto e segurança aos usuários.
- 31. Fornecimento de uniformes para os servidores**, promovendo identificação profissional, conforto e valorização da equipe.
- 32. Garantir locais de trabalho salubres, com climatização adequada**, uma vez que o uso de equipamentos de proteção individual deixa o trabalhador em condições de superaquecimento para o desempenho de suas funções.
- 33. Contratação de assistentes administrativos para compor o quadro de funcionários das Unidades Básicas de Saúde (UBS)**. A ausência desses profissionais tem acarretado sobrecarga administrativa e o consequente desvio de função dos demais membros da equipe. A necessidade de escalas rotativas para suprir demandas de recepção compromete o tempo dedicado às atividades finalísticas de assistência, gerando prejuízos à continuidade do cuidado.

- 34. Estabelecer a isonomia remuneratória** entre profissionais da rede municipal de saúde que possuam o mesmo grau de formação acadêmica (técnico, graduação ou pós-graduação) e que desempenhem funções de igual complexidade e responsabilidade.
- 35. Criar um centro de referência especializado no atendimento integral à saúde física e mental dos servidores municipais**, oferecendo assistência médica, psicológica e suporte terapêutico preventivo.
- 36. Definição de fluxos informativos nas UBS com o intuito de esclarecimento** , garantindo que usuários tenham acesso a informações organizadas e eficientes.
- 37. Revisão do horário do programa Saúde na Hora nas unidades até às 19:30.** A medida considera a análise da segurança e da efetividade do horário estendido, visando garantir a proteção de usuários e profissionais.
- 38. Fortalecimento da fiscalização dos prestadores de serviços de saúde**, abrangendo tanto a qualidade dos atendimentos quanto o correto preenchimento de guias, receitas e formulários padronizados. A proposta visa reduzir erros recorrentes nesses documentos, que têm gerado retrabalho para os servidores das UBS, além de contribuir para maior organização, agilidade e eficiência nos fluxos de atendimento.
- 39. Reestruturação das Unidades Básicas de Saúde (UBS):** Substituição de UBS instaladas em imóveis alugados e inadequados por unidades próprias, planejadas e com infraestrutura adequada para garantir qualidade no atendimento à população.
- 40. Revisão e alinhamento de protocolos de saúde, alinhando** - os aos padrões estaduais e nacionais — como ampliação da idade para mamografia e inserção do Implanon.
- 41. Reorganização dos serviços na UBS**, garantindo a continuidade do cuidado e evitando sobrecarga da unidade com demandas descentralizadas, preservando a qualidade do atendimento.
- 42. Descentralização dos prestadores de serviços para realização de exames e atendimentos especializados**, de modo que esses serviços sejam ofertados em locais mais próximos dos usuários utilizando como parâmetro para agendamento via sistema a Unidade de Saúde de referência do usuário, facilitando o acesso da população e reduzindo deslocamentos para outras regiões do município, diminuindo também o absenteísmo.

ZONA RURAL

PROPOSTAS GERAIS:

- 1. Garantir maior celeridade na realização de exames de alto custo**, propõe-se a ampliação da rede de especialistas credenciados e a implementação de protocolos prioritários de agendamento.

2. **Construção do ponto de apoio de saúde na Comunidades de Lagoa dos Freitas** para melhorar a cobertura assistencial, facilitar o acesso da população a consultas e procedimentos básicos e fortalecer o atendimento na zona rural.
3. **Descentralizar os serviços laboratoriais** por meio da realização de coletas na zona rural, ampliar o acesso da população a exames laboratoriais básicos, reduzir o deslocamento dos usuários até a sede do município e garantir maior agilidade, equidade e qualidade no atendimento à saúde.
4. **Disponibilizar consultas com especialistas nas unidades de saúde da zona rural**, ampliando o escopo de especialidades ofertadas, com o objetivo de ampliar o acesso da população a atendimentos especializados, reduzir a necessidade de deslocamento até a sede do município e promover maior resolutividade, equidade e qualidade na assistência à saúde.
5. **Garantir o acesso a farmácias por meio das equipes na zona rural/pontos de apoio**, proporcionando atendimento igualitário, visto que muitos moradores não têm condições de se deslocar até a zona urbana ou até a Unidade Básica de Saúde da referida equipe.
6. **Garantir o transporte de usuários residentes na zona rural** para a realização de exames e consultas com especialistas na zona urbana.
7. **Aumentar o horário de atendimento dos serviços de saúde para a população rural, como nos finais de semana e horários estendidos**, garantindo maior acesso a consultas, procedimentos e acompanhamento médico, reduzindo deslocamentos e promovendo cuidado contínuo e de qualidade para toda a comunidade.
8. **Ampliar o atendimento nas comunidades rurais**, redividindo o território ou ampliando as equipes de saúde para que localidades que atualmente recebem atendimento quinzenal ou mensal passem a contar com atendimento semanal, garantindo maior regularidade e acesso aos serviços de saúde.
9. **Promover celeridade nos agendamentos de exames e consultas especializadas**, reduzindo o tempo de espera, facilitando o acesso da população a diagnósticos e tratamentos e garantindo um atendimento de saúde mais eficiente e oportuno.
10. **Estender horários de vacinação nas comunidades**, para que todas as pessoas que procuram por esse serviço sejam atendidas no dia de vacinação, sem distribuição de senhas.
11. **Aumentar as cotas de exames especializados** (como ultrassonografia, densitometria, audiometria e raio-X) para garantir que a população tenha acesso mais rápido a diagnósticos, reduzir filas e atrasos, e promover um atendimento médico mais eficiente e equitativo para todos os pacientes.
12. **Ampliar a disponibilidade de medicamentos nas farmácias da zona rural**, expandindo o escopo de medicação oferecida, garantindo que a população local tenha acesso contínuo e adequado aos tratamentos necessários.

- 13. Implementação de laboratório itinerante na zona rural** para melhorar e facilitar o acesso aos exames laboratoriais.
- 14. Reduzir a burocracia no sistema de saúde**, principalmente em parceria com o Ministério da Saúde, e criar estratégias específicas para facilitar o acesso da população aos serviços, especialmente na zona rural, garantindo atendimento mais rápido, eficiente e equitativo para quem vive em áreas afastadas.
- 15. Garantir a continuidade do atendimento com especialistas**, assegurando que o paciente seja acompanhado sempre pelo mesmo profissional, promovendo cuidado mais eficiente, personalizado e de qualidade.
- 16. Ambulâncias** devidamente equipadas e com motoristas para as comunidades rurais.
- 17. Criação do SAMU Rural** para facilitar o atendimento às urgências e emergências na zona rural, garantindo resposta mais rápida, redução do tempo de deslocamento, ampliação do acesso aos serviços de saúde e maior resolutividade no cuidado às populações rurais.
- 18. Aumentar o número de equipes de saúde e profissionais**, evitando sobrecarga, garantindo atenção adequada e contínua, e melhorando a qualidade do atendimento à população, especialmente na zona rural.
- 19. Melhorar o atendimento domiciliar na zona rural**, garantindo visitas domiciliares regulares de profissionais de saúde, oferecendo cuidado personalizado, prevenindo doenças e promovendo a qualidade de vida da população local.
- 20. Ampliar o acesso às mamografias e ultrassonografias das mamas**, aumentando a oferta de exames para garantir rastreamento regular, detecção precoce de doenças e atendimento mais ágil, reforçando a saúde da mulher como prioridade e contribuindo para a redução da morbimortalidade e melhoria da qualidade de vida.
- 21. Realização de processo seletivo para Agentes Comunitários de Saúde (ACS)** com o objetivo de suprir as microáreas descobertas e fortalecer a atenção básica. A iniciativa visa ampliar a cobertura dos serviços de saúde e melhorar o acompanhamento das famílias.
- 22. Construção da sede para o ponto de apoio na comunidade de Camela**, atualmente o atendimento acontece na sede da Associação.
- 23. Implantar ambulatórios itinerantes**, por meio de unidades móveis de atendimento, para levar serviços de saúde às comunidades mais distantes, garantindo acesso equitativo, prevenção de doenças e acompanhamento médico contínuo.
- 24. Ampliar o número de agentes de saúde na zona rural**, considerando o crescimento da população e a alta demanda por atendimentos, garantindo um acompanhamento mais eficiente nas comunidades.

- 25. Realizar agendamentos de exames e consultas especializadas para pacientes da zona rural apenas no turno matutino**, considerando as dificuldades de deslocamento por transporte público e ônibus, otimizando o atendimento e facilitando o acesso da população aos serviços de saúde.
- 26. Adequar o acesso ao atendimento médico na zona rural**, ampliando a frequência dos atendimentos e evitando a limitação do número de consultas por dia, a fim de garantir uma assistência mais equitativa e adequada às necessidades da população residente no território rural.
- 27. Melhorar a organização dos horários médicos nas comunidades**, estabelecendo turnos fixos e bem definidos para atendimento, a fim de evitar atrasos, faltas e garantir maior eficiência e previsibilidade no acesso à saúde.
- 28. Oferecer suporte adequado a pacientes acamados**, capacitando as equipes de saúde para superar limitações no atendimento domiciliar e garantindo cuidado seguro, humanizado e de qualidade.
- 29. Garantir prioridade na realização de exames e cirurgias para a população da zona rural**, considerando os critérios de necessidade clínica e urgência, de modo a assegurar acesso mais rápido e equitativo aos serviços de saúde.
- 30. Garantir a implantação de atendimento com médico oftalmologista nas áreas rurais**, ampliando o acesso da população a consultas especializadas, diagnóstico precoce e tratamento de doenças oculares, promovendo maior equidade no acesso aos serviços de saúde.
- 31. Fortalecer programas de atendimento domiciliar**, como o Melhor em Casa, principalmente para pacientes acamados e moradores da zona rural.
- 32. Garantir atendimento com equipe multidisciplinar** (psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista e assistente social) para pacientes que necessitam de acompanhamento contínuo, principalmente para pacientes com doenças crônicas e necessidades especiais.
- 33. Criação do serviço de transporte sanitário gratuito** dedicado ao atendimento de pacientes com destino a rede de atendimento hospitalar, com estabelecimento de horários fixos de ida e volta, objetivando otimizar o fluxo de pacientes, garantindo a pontualidade nos atendimentos e minimizando as faltas por dificuldades de deslocamento.
- 34. Garantir o reconhecimento dos profissionais médicos da zona rural** por meio de salários justos, valorizando seu trabalho, incentivando a permanência na região e promovendo a qualidade do atendimento à população.
- 35. Fortalecer a fiscalização dos prestadores de serviços de saúde**, abrangendo tanto a qualidade dos atendimentos quanto o correto preenchimento de guias, receitas e formulários padronizados, garantindo que atendam corretamente às chamadas e forneçam informações precisas. A proposta visa reduzir erros recorrentes, evitar deslocamentos desnecessários da população até a cidade, minimizar retrabalho para os servidores das

UBS e contribuir para maior organização, agilidade e eficiência nos fluxos de atendimento.

- 36. Ampliar o atendimento para crianças da zona rural com Transtorno do Espectro Autista (TEA)**, garantindo diagnóstico precoce e acompanhamento contínuo por equipe multidisciplinar, promovendo desenvolvimento adequado e apoio às famílias.
- 37. Fortalecer o acompanhamento de idosos**, garantindo acesso contínuo a consultas, exames e atendimento domiciliar quando necessário, promovendo cuidado integral e qualidade de vida para a população idosa.
- 38. Ampliar o acesso ao atendimento em saúde mental**, por meio da oferta de consultas psicológicas e psiquiátricas, fortalecendo a rede de atenção psicossocial e garantindo cuidado integral, contínuo e de qualidade à população.
- 39. Garantir atendimento especializado e acompanhamento contínuo para pessoas com deficiência**, com acesso à reabilitação e a equipe multiprofissional, promovendo cuidado integral, inclusão e melhoria da qualidade de vida.
- 40. Fortalecer a educação em saúde nas comunidades rurais e escolas**, promovendo ações preventivas, conscientização sobre cuidados básicos e melhoria da qualidade de vida da população.
- 41. Ampliar a estrutura das Unidades Básicas de Saúde na zona rural**, aumentando os pontos de apoio e consultórios adequados, garantindo melhores condições de atendimento, conforto e eficiência para a população local.
- 42. Realização de mutirões de exames e cirurgias** para reduzir filas de espera e agilizar o atendimento da população rural, preferencialmente nos dias da semana, devido a dificuldade de transporte dos usuários da zona rural nos finais de semana.
- 43. Garantir o acesso aos profissionais** incluindo assistente social, fisioterapeuta, educador físico e nutricionista fortalecendo o atendimento integrado e ampliando o cuidado às comunidades da zona rural.
- 44. Propiciar ambientes devidamente equipados** para atendimentos na zona rural.
- 45. Contratar profissionais feristas para cobrir equipes durante férias ou afastamentos** por atestado, garantindo a continuidade do atendimento e evitando interrupções nos serviços de saúde à população.
- 46. Garantir o atendimento médico** realizado no ponto de apoio do Mercado Central, sem a necessidade do encaminhamento prévio, facilitando o acesso direto dos usuários e promovendo maior agilidade, equidade e resolutividade na assistência à saúde.

PROPOSTAS GERAS - POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA

1. **Ampliação do serviço de transporte sanitário para a população em situação de rua.**
2. **Implantação de Centro de apoio ao Consultório na Rua.** Criar estrutura adequada para atendimento contínuo à população em situação de rua, incluindo acompanhamento de pacientes no pós-alta.
3. **Melhoria da estrutura física e organizacional do Abrigo Municipal, incluindo adequações na infraestrutura, melhoria da qualidade das refeições, com o objetivo de qualificar o acolhimento e garantir melhores condições de funcionamento e assistência aos usuários.**
4. **Criação de serviço integrado para atendimento à população em situação de rua.** Implantar atendimento articulado entre a Secretaria Municipal de Saúde e de Desenvolvimento Social, com ações conjuntas e fluxo unificado.
5. **Ampliação das equipes do Consultório na Rua.** Criar uma terceira equipe para ampliar a cobertura e o atendimento à população em situação de rua, com atendimento noturno.
6. **Implementação de um serviço de pós-alta específico para a população de rua.**
7. **Ampliação do número de veículos exclusivos para as equipes de Consultório na Rua,** tanto para uso nas rotas quanto para transporte de pacientes para as consultas.
8. **Disponibilização de um Odontomóvel específico para equipe de Consultório na Rua.**
9. **Contratação/adequação de serviço de motorista específico para rotas referentes à Unidade Móvel de Atendimento Odontológico (UOM),** para equipe de Saúde Bucal do Consultório na Rua.
10. **Realizações de ações de educação permanente para profissionais de saúde e assistência social,** fortalecendo a oferta de capacitações contínuas para equipes que atuam com a população em situação de rua.
11. **Criação de Unidade de Acolhimento Noturno Integrado Saúde/Desenvolvimento Social próxima ao Centro Pop,** ampliando o serviço para atendimento à população em situação de rua no período noturno.
12. **Implantar pontos de apoio descentralizados nos extremos do município, destinados à população em situação de rua,** com oferta de serviços essenciais como acolhimento, higiene, alimentação, escuta qualificada e encaminhamentos para a rede de saúde e assistência social, garantindo maior acesso e cobertura territorial.

- 13. Ampliar o serviço de busca ativa voltado à saúde mental de pacientes em situação de rua**, garantindo acompanhamento contínuo e acesso facilitado aos cuidados necessários.
- 14. Implantação de duas Unidades de acolhimento adulto mistas para a população**, (justificativa: capacidade populacional prevista para atender à demanda).
- 15. Construção de sede própria para a equipe de Consultório na Rua**, localizada na região central, a fim de facilitar o acesso e qualificar a oferta de serviços, inclusive, com espaço destinado à higiene pessoal dos pacientes.
- 16. Expansão do laboratório de prótese dentária e da oferta de consultas especializadas em prótese dentária, com cota específica para pacientes em situação de rua.**

PROPOSTAS GERAIS - IGUALDADE RACIAL:

- 1. Implementar a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra no município**, com a oferta de serviços de saúde considerando as necessidades específicas desse público, em horários alternativos e ampliados, para além do programa Saúde na Hora. Tal medida se justifica pelo fato de que grande parte dessa população exerce atividades laborais em horário comercial, o que dificulta o acesso aos atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de referência.
- 2. Criar uma coordenação específica** no âmbito da gestão municipal de saúde, com a finalidade de assegurar a implementação, o fortalecimento e o monitoramento da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, garantindo a equidade no acesso, na atenção e nos resultados em saúde para esse público, por meio da implantação de um sistema contínuo de monitoramento dos dados, com análise sistemática de indicadores prioritários, subsidiando o planejamento, a tomada de decisão e a qualificação das ações em saúde com foco na equidade.
- 3. Implementar estratégias antirracistas** nos serviços do Sistema Único de Saúde.
- 4. Realizar processo seletivo para Agentes Comunitários de Saúde (ACS)** com o objetivo de suprir as microáreas descobertas e fortalecer a atenção básica. A iniciativa visa ampliar a cobertura dos serviços de saúde e melhorar o acompanhamento das famílias.
- 5. Implementar e fortalecer estratégias para a efetiva implementação da Lei nº 10.639/2003 nas grades curriculares dos cursos de formação na área da saúde**, assegurando a inclusão sistemática de conteúdos relacionados à história e cultura

afro-brasileira e africana, bem como à promoção da equidade racial no cuidado em saúde.

6. **Implementar estratégias de letramento racial interseccional** para profissionalizar gestores e comunidades visando reduzir os impactos do racismo nas políticas públicas de saúde nos níveis municipal, estadual e federal.
7. **Instituir um canal oficial, acessível e seguro para o recebimento de denúncias de racismo e/ou injúria racial**, garantindo sigilo, acolhimento qualificado às vítimas, fluxo definido para apuração dos casos e encaminhamento das providências cabíveis, com monitoramento contínuo e transparência nos resultados. Este serviço deve ser vinculado ao Conselho Municipal de Saúde articulado com o Conselho/Coordenadoria Municipal de Igualdade Racial.
8. **Atualizar portaria do grupo de Humanização** para incluir a pauta das políticas públicas voltadas à população negra com o objetivo de ampliar a discussão dessa temática.
9. **Implementar, no âmbito do SUS**, um modelo de atenção integral e humanizada às mulheres negras em situação de violência doméstica, com escuta qualificada, sigilo e respeito às especificidades étnico-raciais e de gêneros.
10. **Implementar formação permanente das equipes de saúde** para identificação precoce da violência doméstica, abordagem antirracista e não revitimizadora, além da ampliação ao atendimento psicológico, com encaminhamentos seguros à rede de cuidado.
11. **Implantar dispositivo de comunicação** entre os serviços de saúde e de assistência social, a fim de atender demandas de forma conjunta.
12. **Criar comitê intersetorial** (saúde, educação e desenvolvimento social) ligado diretamente à secretaria de governo, a fim de levar as demandas levantadas diretamente ao prefeito.

PROPOSTAS GERAIS - POPULAÇÃO LGBTQIAPN+:

1. **Propõe-se atendimento psicológico e saúde mental para adolescentes e jovens.** Garantir atendimento psicológico e acompanhamento em saúde mental para adolescentes e jovens que questionam sua identidade de gênero ou sexualidade. Este atendimento deve ser discreto, sigiloso, acolhedor e livre de preconceito, de modo a reduzir a evasão do serviço por medo de discriminação e garantir a saúde mental dessas pessoas.

2. Propõe-se apoio e orientação às famílias. Ampliar e qualificar os serviços voltados às famílias que desejam apoiar e acompanhar o processo de transição de gênero de seus familiares. O suporte deve incluir orientação adequada, escuta qualificada e acompanhamento psicossocial contínuo, promovendo uma abordagem humanizada, inclusiva e fortalecendo os vínculos familiares.

3. Propõe-se estrutura inclusiva nos espaços públicos. Instituir banheiros de uso neutro em espaços públicos, como medida de promoção da saúde, dignidade e inclusão. Esta ação visa reduzir o risco de infecções urinárias e constrangimentos enfrentados por pessoas trans que evitam banheiros convencionais devido à inadequação ou insegurança em relação à sua identidade de gênero.

4. Propõe-se conscientização e prevenção de ISTs. Promover ações de conscientização sobre formas de transmissão de ISTs e práticas seguras de sexualidade dentro da comunidade LGBTQIAPN+, utilizando cartilhas, propagandas em redes sociais, eventos públicos e outros meios de ampla divulgação, assegurando acesso à informação de qualidade e prevenção de doenças.

5. Fortalecimento de ambulatorios transexualizadores. Ampliar e qualificar a divulgação dos ambulatorios transexualizadores, garantindo acesso à informação sobre os serviços oferecidos, fluxos de atendimento e formas de acesso. Essa medida visa promover inclusão, cuidado integral, humanizado e seguro à população trans.

6. Propõe-se política de atenção integral à saúde LGBTQIAPN+ no SUS. Implementar e fortalecer políticas públicas de atenção integral à saúde para a população LGBTQIAPN+ no SUS, assegurando acolhimento humanizado, respeito ao nome social e à identidade de gênero, capacitação permanente dos profissionais de saúde e ampliação do acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de atenção.

7. Propõe-se atendimento em saúde mental nas UBS e escolas. Ampliar e qualificar o atendimento em saúde mental nas Unidades Básicas de Saúde e escolas, oferecendo espaços acolhedores, sigilosos e livres de preconceito, para que estudantes e usuários possam dialogar sobre dúvidas relacionadas à sexualidade e identidade de gênero, fortalecendo a saúde mental e a inclusão social.

8. Propõe-se capacitação continuada de profissionais de saúde. Promover capacitações regulares e continuadas para equipes da atenção primária e serviços especializados, assegurando atendimento humanizado, inclusivo e livre de discriminação, com foco na abordagem integral das necessidades da população LGBTQIAPN+.

9. Propõe-se capacitação de profissionais da educação. Promover capacitação contínua de professores e profissionais da educação em letramento LGBTQIAPN+, fortalecendo práticas pedagógicas inclusivas, o respeito à diversidade e a criação de ambientes escolares seguros, acolhedores e livres de discriminação.

10. Propõe-se convênios com ginecologistas e urologistas especializados. Estabelecer convênios com profissionais especializados em ginecologia e urologia para atender a população LGBTQIAPN+, garantindo cuidado qualificado, humanizado, inclusivo e livre de discriminação.

11. Propõe-se cirurgias de redesignação de gênero. Estabelecer convênios para realização de cirurgias de redesignação de gênero para pessoas transexuais, assegurando acesso seguro, qualificado e humanizado, com acompanhamento multiprofissional em todas as etapas do cuidado.

12. Propõe-se exames para hormonização. Garantir cota específica para a realização de exames laboratoriais de pacientes em processo de hormonização, assegurando acompanhamento contínuo, cuidado integral e acesso oportuno aos serviços de saúde.

13. Propõe-se grupos de trabalho e articulação com universidades. Criar grupos de trabalho compostos por movimentos sociais, universidades e pesquisadores para atuação junto aos ambulatorios especializados em saúde LGBTQIAPN+, fortalecendo a integração entre sociedade civil, academia e serviços de saúde.

14. Propõe-se capacitação para acolhimento de usuários e trabalhadores do SUS. Assegurar a capacitação de profissionais do SUS para acolher adequadamente tanto usuários quanto trabalhadores LGBTQIAPN+, garantindo um ambiente de atendimento inclusivo, seguro e livre de preconceito.

15. Propõe-se reavaliação de currículos de cursos de saúde. Reavaliar os Projetos Político-Pedagógicos e currículos de cursos da área da saúde, inserindo disciplinas que abordem temáticas LGBTQIAPN+ e garantindo atividades de extensão universitária junto ao público LGBTQIAPN+, com foco na formação em saúde de profissionais inclusivos e qualificados.

16. Propõe-se a participação da população LGBTQIAPN+ no controle social. Garantir a participação da população LGBTQIAPN+ nas instâncias de controle social do SUS, incluindo reserva de assento no Conselho Municipal de Saúde, fortalecendo a democracia sanitária e a representatividade nas decisões sobre políticas públicas de saúde.

17. Propõe-se a inserção da temática LGBTQIAPN+ no Plano Municipal de Saúde. Garantir que o Plano Municipal de Saúde contemple de forma efetiva a população LGBTQIAPN+, com inclusão de metas, indicadores e estratégias de monitoramento para assegurar atenção integral, humanizada e inclusiva.

18. Propõe-se o reforço de legislações específicas. Reforçar a necessidade de criação e implementação de legislações específicas nos âmbitos municipal, estadual e federal, visando à proteção dos direitos da população LGBTQIAPN+ e à garantia de políticas públicas duradouras e efetivas.

19. Propõe-se criar um canal acessível, seguro e eficiente para registro, acompanhamento e encaminhamento de denúncias de discriminação em serviços de saúde, assegurando sigilo total das informações, respostas institucionais adequadas e melhoria contínua do atendimento.

20. Propõe-se desenvolver programas específicos de prevenção à depressão, ansiedade e suicídio na população LGBTQIAPN+, oferecendo atendimento psicológico gratuito realizado por profissionais capacitados.

21. Propõe-se garantir o acesso ao processo transexualizador, incluindo hormonização corporal, com acompanhamento seguro por equipe multidisciplinar composta por psicólogo, endocrinologista e assistente social.

22. Propõe-se promover a articulação entre os poderes públicos (executivo, legislativo e judiciário) e instâncias de participação social, como movimentos sociais, para assegurar a presença da população LGBTQIAPN+ em conselhos e comitês, construindo fluxos efetivos de acolhimento e atendimento.

23. Propõe-se criar um comitê intersetorial permanente para garantir atendimento acolhedor, humanizado e equânime, articulando saúde, educação e assistência social, com fluxos definidos e atuação conjunta, especialmente para monitorar casos complexos.

24. Propõe-se garantir a adesão do município a programas voltados à população LGBTQIAPN+.

25. Propõe-se implantar sistemas de produção de indicadores em saúde para identificar demandas e necessidades da população LGBTQIAPN+, com ênfase na saúde mental.

26. Propõe-se implementar ações contínuas na política de educação permanente para profissionais dos serviços públicos e privados de saúde e assistência social, promovendo o letramento LGBTQIAPN+ e o enfrentamento de discriminações de gênero e sexualidade.

27. Propõe-se criar um programa de auxílio alimentar que ofereça cestas básicas suficientes para pessoas LGBTQIAPN+ em situação de vulnerabilidade.

28. Propõe-se disponibilizar atendimento nutricional especializado nos ambulatórios para pessoas em processo de desnutrição, com acompanhamento por nutricionista.

29. Propõe-se criar espaços dedicados ou destinar alas específicas em abrigos para acolher pessoas LGBTQIAPN+ em situação de rua ou abandono.

PROPOSTAS GERAIS - SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS:

1. Garantir que o incentivo adicional de qualidade, referente ao componente de financiamento instituído pela Portaria nº 3.493/2024, seja devidamente repassado às equipes de Saúde da Família.
2. Propõe-se a implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) de Montes Claros, garantindo critérios claros de progressão funcional, valorização da experiência profissional e remuneração compatível com as atribuições exercidas.
3. Criar uma Ouvidoria destinada aos trabalhadores, assegurando o sigilo das informações e a confidencialidade das manifestações.
4. Instituir política pública voltada à prevenção, orientação e investigação de casos de assédio no ambiente de trabalho, com estabelecimento de medidas protetivas e ações corretivas destinadas à garantia da integridade e dos direitos dos trabalhadores.
5. Instituir processo de gerenciamento de banco de horas destinado à participação dos trabalhadores em ações de educação permanente, garantindo organização, transparência e equidade no acesso às atividades formativas.
6. Instituir, no organograma do município de Montes Claros, o cargo de Apoiador Institucional da Atenção Primária à Saúde, com definição de atribuições, competências e responsabilidades, visando ao fortalecimento da gestão, qualificação dos processos de trabalho e apoio às equipes de saúde.
7. Instituir, no organograma do município de Montes Claros, o cargo de Enfermeiro Estomatoterapeuta, com definição de atribuições, competências e responsabilidades, visando à qualificação da assistência, especialmente no cuidado a pacientes com feridas, estomias e incontinências, contribuindo para a integralidade do cuidado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
8. Garantir o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) aos profissionais das Unidades Básicas de Saúde (UBS), mediante avaliação técnica das condições de trabalho e em conformidade com a legislação vigente.
9. Garantir o direito ao adicional de periculosidade a todos os trabalhadores expostos a riscos, conforme critérios estabelecidos na legislação vigente e mediante avaliação técnica das condições de trabalho.
10. Propõe-se reorganização do horário de funcionamento das unidades de saúde no município. Considerando a revogação da Lei do programa Saúde na Hora, propõe-se que o município reavalie a manutenção dessa estratégia nas unidades de saúde. Sugere-se o retorno das unidades ao horário padrão de funcionamento, garantindo melhor organização das equipes e das condições de trabalho dos servidores.
11. Propõe-se a ampliação de polos de atendimento com plantão noturno, distribuídos estrategicamente no município, de modo que haja pelo menos um pólo em cada grande região da cidade. Garantir a segurança dos profissionais de saúde durante a atividade laboral, por meio da instalação de câmeras de monitoramento e da disponibilização de vigilância nos locais de trabalho.

12. Criar equipe multiprofissional destinada à assistência aos servidores municipais em situações de urgência e emergência, garantindo atendimento oportuno, integral e qualificados.
13. Propõe-se garantir o pagamento do piso salarial estabelecido em lei para cada categoria profissional que atua no serviço público municipal. Essa medida visa assegurar o cumprimento da legislação vigente, promover a valorização dos trabalhadores e garantir condições dignas de remuneração.
14. Propõe -se investir na melhoria da infraestrutura dos ambientes de trabalho, garantindo espaços adequados, equipamentos suficientes e materiais necessários para o desempenho das atividades.
15. Propõe-se a implementação de políticas voltadas à saúde do servidor, com ações de prevenção de doenças ocupacionais, acompanhamento psicológico e promoção do bem-estar no ambiente de trabalho.
16. Propõe-se a criação e o fortalecimento de espaços permanentes de diálogo entre servidores e gestores municipais, como mesas de negociação e fóruns de discussão.
17. Propõe-se a ampliação de programas de capacitação e formação permanente para os servidores municipais, com oferta de cursos, treinamentos e atualização profissional.
18. Propõe-se garantir financiamento adequado e maior integração entre os diferentes setores da administração pública municipal, visando fortalecer as políticas públicas e melhorar a eficiência dos serviços oferecidos à população. A valorização dos servidores e a organização adequada dos serviços são fundamentais para promover um atendimento mais eficiente, humanizado e resolutivo.
19. Propõe-se garantir o pagamento de adicional de insalubridade aos profissionais que atuam nas UBS, incluindo recepcionista, assistentes administrativos, psicólogos, farmacêuticos, gerentes e apoiadores, conforme avaliação das condições de trabalho e exposição a riscos ocupacionais, em conformidade com a legislação vigente.
20. Propõe-se disponibilizar veículo próprio com motorista para cada Unidade de Saúde da Família, destinado ao deslocamento das equipes nas visitas domiciliares e ao apoio no transporte de usuários da área adscrita, mediante agendamento, ampliando o acesso e a continuidade do cuidado.
21. Criar uma equipe multiprofissional para assistir os servidores municipais em caso de situação de urgência e emergência.
22. Propõe-se que os concursos públicos e processos seletivos municipais passem a considerar o tempo de serviço e a experiência profissional como critérios de pontuação ou classificação, especialmente para servidores que já atuam na rede municipal.
23. Propõe-se a adoção de estratégias que priorizem a permanência e valorização de servidores que já possuem experiência e vínculo com a rede municipal. A manutenção desses profissionais contribui para a continuidade das ações e serviços, preserva o conhecimento acumulado no território e fortalece o vínculo com a população atendida.

24. Propõe-se a implantação de um programa permanente de manutenção preventiva nas Unidades públicas municipais, com o objetivo de garantir melhores condições estruturais e de funcionamento dos serviços.
25. Propõe-se a ampliação das equipes de saúde bucal no município, com a criação de novas equipes e o fortalecimento das já existentes na Atenção Primária à Saúde.
26. Garantir o pagamento de insalubridade com base no 'salário base' para todas as categorias de profissionais da saúde que fazem atendimento direto aos usuários.
27. Propõe-se que o município priorize a utilização do sistema e-SUS Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, evitando a adoção de sistemas terceirizados que não estejam plenamente integrados às plataformas oficiais do Ministério da Saúde. A utilização do e-SUS contribui para a padronização das informações, facilita o registro das ações realizadas pelas equipes, melhora a qualidade dos dados em saúde e fortalece a integração com os sistemas nacionais de informação. Além disso, o uso do sistema oficial favorece o planejamento, o monitoramento e a avaliação das ações de saúde no município, garantindo maior transparência, eficiência na gestão e alinhamento com as diretrizes do Sistema Único de Saúde.
28. Garantir a adequação da ambiência nos locais de trabalho de acordo com as normas de vigilância sanitária garantindo a segurança para profissionais com a climatização, mobiliário e equipamentos que garantem ergonomia.
29. Propõe-se o fortalecimento e a valorização da odontologia na Atenção Primária à Saúde e nos diversos setores da gestão municipal, reconhecendo a importância da saúde bucal como parte essencial do cuidado integral à população. Essa proposta envolve o investimento em melhores condições de trabalho para as equipes de saúde bucal, a ampliação da cobertura assistencial, a garantia de insumos e equipamentos adequados, além do incentivo à qualificação e capacitação permanente dos profissionais.
30. Propõe-se o desenvolvimento de ações e políticas voltadas à promoção, prevenção e cuidado com a saúde dos servidores públicos municipais. Essa proposta inclui a implementação de programas de acompanhamento da saúde física e mental, ações de prevenção de doenças relacionadas ao trabalho, incentivo a práticas de promoção da saúde e melhoria das condições do ambiente laboral.
31. Instituir o Centro Ambulatorial de Medicina Integrativa e de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) no município de Montes Claros, visando à ampliação do cuidado integral, à promoção da saúde e ao bem-estar da população por meio de abordagens terapêuticas complementares.
32. Implantar o benefício de vale-alimentação aos servidores municipais, em quantidade suficiente para atender às suas necessidades básicas, no âmbito do município de Montes Claros.
33. Garantir o pagamento do adicional de insalubridade correspondente a 20% (vinte por cento) para todos os profissionais e trabalhadores da saúde
34. Garantir adicional salarial por qualificação aos profissionais da saúde, de forma não cumulativa, sendo: 5% (cinco por cento) para especialização, 10% (dez por cento) para mestrado e 15% (quinze por cento) para doutorado, acrescidos aos salários mensais.

35. Garantir o repasse do recurso do Programa Farmácia de Minas na forma de gratificação aos profissionais, conforme os critérios e exigências estabelecidos na legislação vigente, no âmbito do município de Montes Claros.
36. Instituir a gratificação para o exercício de funções estratégicas, assegurando isonomia no pagamento entre servidores efetivos e contratados, no âmbito do município de Montes Claros, conforme critérios definidos em legislação vigente.
37. Instituir abono de permanência para todos os profissionais da saúde que atuam nas UBS, assim como em outras lotações da SMS, conforme o plano de carreira, a ser concedido àqueles que permanecem em suas funções, na mesma equipe e circunscrição de trabalho, após o cumprimento do período inicial de 2 (dois) anos ininterruptos de efetivo exercício.
38. Viabilizar a aquisição e disponibilização de bicicletas aos servidores municipais como meio de locomoção para o exercício de suas atividades, promovendo mobilidade sustentável, otimização dos deslocamentos e melhoria das condições de trabalho, no âmbito do município de Montes Claros.
39. Garantir a realização periódica de Conferências da Atenção Básica no município de Montes Claros, como espaço democrático de participação social, avaliação das ações desenvolvidas e construção de propostas para o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde.
40. Garantir a aquisição e disponibilização de novas insulinas pelo município de Montes Claros, conforme protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas vigentes, visando à ampliação do acesso e à melhoria do controle glicêmico dos usuários.
41. Revisar os direitos trabalhistas, assegurando sua inclusão no plano de carreira dos servidores municipais de Montes Claros, conforme a legislação vigente, com vistas à valorização profissional e à garantia de condições dignas de trabalho.
42. Garantir a substituição dos tablets atualmente utilizados por equipamentos que atendam aos requisitos mínimos dos sistemas utilizados pelo município, com desempenho, memória, bateria e capacidade adequados às demandas do serviço, bem como assegurar a aquisição de uniformes apropriados às condições climáticas e à realidade local — especialmente para ACS e ACE — e a disponibilização dos insumos necessários ao desempenho das atividades, visando à qualificação das condições de trabalho e à melhoria dos serviços prestados no município de Montes Claros.
43. Instituir comissão com participação dos servidores para avaliar, aprovar e fiscalizar a qualidade do tecido, do modelo e da durabilidade dos uniformes antes da aquisição em larga escala, no âmbito do município de Montes Claros.
44. Substituir os instrumentos de trabalho em formato físico por sistemas digitais, garantindo que os registros e processos sejam realizados exclusivamente de forma online, com segurança da informação, acessibilidade e capacitação dos servidores, no âmbito do município de Montes Claros, diminuindo o desgaste físico dos profissionais

45. Garantir a realização de treinamentos periódicos sempre que houver atualização e/ ou mudanças nos sistemas, promovendo a padronização do conhecimento e o alinhamento das orientações entre os servidores, no âmbito do município.
46. Garantir que todos os coordenadores possuam conhecimentos mínimos sobre direitos trabalhistas e deveres funcionais, por meio de capacitações específicas e contínuas, no âmbito do município de Montes Claros.
47. Garantir a disponibilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) de qualidade, incluindo óculos de proteção e acessórios adequados para atividades com exposição prolongada ao sol e a agentes ambientais, assegurando proteção eficaz aos servidores, conforme normas técnicas e legislação vigente, no âmbito do município de Montes Claros.
48. Estabelecer a redução da carga horária para 6 (seis) horas diárias aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), no âmbito do município de Montes Claros, conforme legislação vigente e avaliação da viabilidade administrativa e assistencial.
49. Construção de sala para ACS em todas as unidades de saúde para que eles possam realizar o serviço administrativo com computadores;
50. Garantir a aquisição de tablets a cada dois anos para os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE), assegurando atualização tecnológica e condições adequadas para o desempenho das atividades.
51. Instituir processo de fiscalização dos prestadores de serviços, com a participação de representantes da Atenção Básica, incluindo Agentes Comunitários de Saúde (ACS), ou por meio do Conselho Local de Saúde, quando houver, no âmbito do município de Montes Claros, visando ao fortalecimento do controle, da transparência e da qualidade dos serviços ofertados.
52. Promover melhorias na estrutura física das Unidades de Saúde e garantir a disponibilização de insumos adequados aos profissionais, assegurando condições mínimas para a realização do trabalho com qualidade, no âmbito do município de Montes Claros.
53. Atualizar os critérios de avaliação da ficha SSA2 para o fechamento do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB), de modo que estejam alinhados aos novos indicadores de financiamento da atenção básica vigente.
54. Avaliar a exclusão das fichas B e C utilizadas pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS),
55. Instituir o fechamento programado das Unidades Básicas de Saúde (UBS) para a realização do fechamento do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) e para o planejamento das ações do mês subsequente, garantindo organização dos processos de trabalho e qualificação das atividades desenvolvidas.
56. Garantir o fornecimento de calçados adequados às atividades externas — sendo tênis apropriado para os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), em razão das longas caminhadas, e botas para os Agentes de Combate às Endemias (ACE), considerando os

riscos da função — bem como assegurar a entrega completa do fardamento básico, incluindo calça, blusa, chapéu, protetor solar e demais itens necessários ao exercício seguro e digno das atividades, no âmbito do município de Montes Claros.

57. Garantir a disponibilização de mochila ou bolsa funcional adequada para o transporte de materiais utilizados nas visitas domiciliares e ações de campo, bem como o fornecimento regular de materiais de expediente e apoio indispensáveis à rotina de trabalho, no âmbito do município de Montes Claros.
58. Realizar a reterritorialização de todas as equipes de forma equitativa, considerando critérios como áreas de risco e vulnerabilidade, bem como promover a contratação de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) por meio de processo seletivo ou concurso público até dezembro de 2026, no âmbito do município de Montes Claros.
59. Instituir no âmbito municipal diretrizes para adesão e implementação da carreira interfederativa do SUS em articulação com os entes Estadual e federal contemplando estruturação de carreira com progressão baseada em tempo de serviço, qualificação e desempenho; padronização mínima de direitos, remuneração e jornada; mecanismos de mobilidade interfederativa regulados; incentivo à fixação de profissionais em áreas de maior vulnerabilidade; integração com políticas de educação permanente em saúde.
60. Garantir a disponibilização de internet Wi-Fi nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), assegurando condições adequadas para a realização das atividades pelos profissionais, comunicação entre equipes e atendimento aos usuários, evitando a utilização de recursos próprios e reduzindo atrasos no fluxo de atendimento.
61. Definir e direcionar profissionais responsáveis pela inserção de exames nas filas, sejam eletivas ou de urgência, garantindo organização, agilidade e transparência no acesso aos serviços, no âmbito do município de Montes Claros.
62. Garantir a distribuição de tablets a todos os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que ainda não dispõem do equipamento, assegurando condições adequadas para o desempenho das atividades, incluindo funcionalidades de geolocalização compatíveis com as exigências do serviço.
63. Promover a ampliação do espaço físico das Unidades Básicas de Saúde que possuem mais de três equipes, visando à melhoria das condições de trabalho, organização dos serviços e qualidade do atendimento prestado.
64. Implantação de divulgação e repasse de informações com rapidez e clareza onde não haja divergência entre o que foi dito pela secretaria e o repassado para o paciente;
65. Padronização e direcionamento com clareza de responsabilidades de lançamentos de exames e demandas via sistema mais saúde digital, os quais em determinadas unidades

são terceirizadas aos ACS que muitas das vezes fazendo trabalho de recepção e administração, não entendem letras de médicos e etc. Vindo a lançar exames errados, tendo acesso lançam exames por conta própria superlotando assim as filas aos quais se torna repetitivo a fala do paciente “perdi o pedido”. Medidas mais drásticas precisam ser tomadas;

66. Fortalecer a saúde do trabalhador no serviço público municipal, integrando ações de medicina ocupacional, vigilância em saúde do trabalhador, CEREST e controle social, com foco na prevenção e enfrentamento dos riscos ergonômicos e psicossociais;
67. Estruturar a medicina ocupacional, fortalecer o CEREST com recursos humanos, insumos e logística, ampliar a vigilância nos ambientes de trabalho e promover educação permanente e participação dos trabalhadores no controle social;
68. Reconhecer os servidores da Vigilância em Saúde do Trabalhador como autoridade sanitária, garantindo respaldo legal, capacitação específica, suporte jurídico e integração com outros órgãos de fiscalização, para maior efetividade nas ações de vigilância e proteção dos direitos dos trabalhadores; Garantir o reajuste anual dos pagamentos de plantões noturnos, de acordo com o Plano de Cargos e Salários (PCA) e o índice de inflação, assegurando valorização e correção salarial dos servidores municipais
69. Implantar um Pronto Atendimento exclusivo para os servidores municipais, dentro da estrutura da Prefeitura, garantindo acesso rápido, atendimento qualificado e adequado às demandas de saúde do corpo funcional.
70. Realizar busca ativa em saúde do trabalhador por meio de equipe multiprofissional, visando à prevenção, acompanhamento e promoção da saúde dos servidores municipais.
71. Criar o Centro Humanizado “Amigo do Servidor”, oferecendo acolhimento, práticas integrativas de saúde e demais serviços voltados ao bem-estar físico, mental e emocional dos servidores municipais.
72. Criação de equipe multiprofissional para busca ativa e motivação a saúde dos trabalhador;
73. Contratação de ferista para serviços públicos para evitar sobrecarga do profissional que vai entrar de férias ou dos que estão trabalhando;
74. Estimular a gestão municipal a ampliar o diálogo com os servidores, promovendo discussões sobre novas ideias e estratégias, inclusive em articulação com outros gestores municipais do país, visando à melhoria contínua dos serviços públicos.
75. Estabelecer a exigência de justificativa clara e fundamentada para demissões sem justa causa, garantindo transparência e proteção aos direitos dos servidores municipais.
76. Estruturar o funcionamento do banco de horas, definindo regras claras para a compensação de jornada e garantindo controle transparente das horas trabalhadas pelos servidores municipais.

77. Garantir a disponibilidade de médicos e outros profissionais de saúde para substituição imediata em caso de ausência do titular, assegurando a continuidade e a qualidade do atendimento.
78. Garantir que o Secretário e demais autoridades tenham espaço para manifestação, mas priorizando a escuta ativa dos servidores, valorizando suas demandas e sugestões. Que o prefeito escute a fala dos servidores pois nos eventos apenas fala e depois sai.
79. Promover melhorias na infraestrutura das Unidades de Saúde, garantindo condições adequadas para a realização das atividades laborais diárias.
80. Garantir o reajuste anual dos pagamentos de plantões noturnos, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, assegurando a valorização e a correção salarial dos servidores municipais.
81. Garantir pagamento adicional ao cirurgião-dentista que exerça a função de responsável ou referência técnica na Unidade Básica de Saúde, conforme previsto em legislação vigente.
82. Efetivar a aplicação da **NR-1 (Norma Regulamentadora nº 1)**, garantindo que todas as disposições sobre **disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais** sejam implementadas e cumpridas nas unidades de trabalho, assegurando a proteção, segurança e saúde dos servidores municipais.
83. Valorizar a **FarmaVerde**, fortalecendo suas atividades de estudo e serviços, incluindo o desenvolvimento e fortalecimento da pesquisa com **cannabis medicinal**, promovendo capacitação de profissionais, melhorias estruturais e ampliação da eficiência no atendimento
84. (Monção de repúdio à fala na Pré Conferência que diz que quando o usuário se mostra insatisfeito com o sus é por falta de caráter, falta de responsabilidade e falta de compromisso do servidor e na fala o relator orienta que o servidor peça para sair. Repúdio toda forma de transformação de responsabilidade ou incompreensão com a saúde física, mental e emocional do servidor.) Em resposta não vamos pedir para sair, vamos lutar para melhorar!
85. Ampliar o “Centro Humanizado Amigo do Servidor” para espaço com rodas de conversas, clube de leitura com cronograma fixo para os servidores se planejarem para participar uma vez ao mês.
86. Garantir a liberação dos profissionais da saúde para participação em cursos de especialização e capacitação, contabilizando essas atividades dentro da carga horária de trabalho, sem necessidade de reposição desta.
87. Instalar banheiros adicionais para uso feminino nos pontos de apoio dos Agentes de Combate às Endemias (ACE), garantindo melhores condições de higiene, conforto e atendimento às necessidades específicas das servidoras.

88. Informatização das solicitações de exames, para que os prestadores possam acessar os pedidos pelo sistema e evitar voltar o paciente;
89. Criação de Whatsapp institucional considerando que a maior comunicação hoje é com os pacientes é via Whatsapp;
90. Criar o cargo de coveiro/sepultador, pagar a insalubridade 40%, EPI adequado e atendimento psicológico.
91. Implantar aplicativo para atender os servidores da educação e saúde das demais ouvidorias e melhores condições e apoio.
92. Retomar as gratificações DAS e DAI para funções estratégicas de cargos efetivos.